UE A2.1 · SEMESTRE 1

DROITS DES PATIENTS

Fiche de révision écrite · droits et décisions en situation de soins

Supports officiels et notes de cours

Pourquoi cette fiche ?

Comprendre les droits de la personne soignée **et leurs limites**, puis savoir les appliquer : informer, recueillir une volonté, respecter le secret, protéger la dignité et tracer les décisions.

Priorités explicitement soulignées

- Prévenir, évaluer et soulager la douleur ; **tracer** les évaluations.
- Vérifier la compréhension réelle du patient après l'information, et pas seulement la diffusion du message.

Lecture à deux niveaux

Pour comprendre : principes, conditions, exceptions et distinctions.
En pratique : consentement/refus, secret, dossier, fin de vie, mineurs, protection juridique, psychiatrie et recours.

Une seule démarche : 5 réflexes avant de décider

Étape	Question à se poser
1 · Identifier	Qui demande ? Quelles capacités et quel cadre juridique ?
2 · Expliquer	Quelle règle, quelles conditions et quelles exceptions ?
3 · Rechercher	Que souhaite la personne ? Quel consentement ou refus ?
4 · Agir	Que puis-je décider et accomplir dans mon rôle ?
5 · Tracer / vérifier	Quelles informations et quel suivi documenter ?

Sommaire rapide — accès direct aux chapitres

Fondements, dignité, accès p. 2
Fin de vie, sédation, aide à mourir p. 4
Choix, secret, partage p. 7
Information et consentement p. 9
Mineurs et majeurs protégés p. 12
Soins psychiatriques p. 14
Dossier médical p. 16
Droits à l'hôpital et recours p. 17
Pièges QCM p. 33
Synthèse générale p. 34
Définitions et mots-clés p. 36

Réflexe de partiel

Une règle n'est jamais absolue sans vérifier **la personne concernée, le consentement, la situation d'urgence, les exceptions et la traçabilité**.

01 · Fondements, dignité et accès aux soins

Objectifs

Comprendre les règles, leurs conditions et leurs exceptions; protéger l'autonomie et la dignité; savoir informer, recueillir la volonté et tracer; distinguer les régimes du mineur, du majeur protégé et des soins psychiatriques.

1 Des droits construits progressivement

Support officiel, p. 2

Les droits des usagers se sont construits par la jurisprudence avant leur organisation par la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. L'arrêt Mercier du 20 mai 1936 marque la relation contractuelle et l'exigence de soins consciencieux conformes à la science. L'arrêt Teyssier du 28 janvier 1942 affirme la nécessité du consentement. Les arrêts Martin du 29 mai 1951 et Dame Angamarre du 21 février 1961 participent à la reconnaissance de l'information.

L'arrêt Hédreul du 25 février 1997 place la preuve de l'information à la charge du professionnel. Cette évolution soutient le passage d'un modèle paternaliste à une décision partagée. L'usager ne se réduit pas à une personne malade: prévention et dépistage ouvrent aussi des droits. Le patient reste sujet de droit et acteur des décisions concernant sa santé.

1936 Relation de soins et responsabilité

1942 Consentement

1997 Preuve de l'information

2002 Organisation légale des droits

> **À retenir.** Information, consentement et preuve structurent la relation de soins.

2 Responsabilités du patient et protection des soignants

Support officiel, p. 3-7

Les droits des usagers s'accompagnent de responsabilités destinées à préserver le système de santé. Cette formulation générale n'instaure pas, à elle seule, une sanction précise ni une obligation générale de se soigner. La collaboration consiste notamment à donner les informations utiles sur symptômes, antécédents et traitements et à tenir compte des conseils reçus. Le droit de refuser un traitement demeure. Une faute du patient peut contribuer au dommage et réduire la responsabilité du praticien, qui doit cependant avoir recherché les informations utiles.

Le règlement intérieur organise la vie de l'établissement. En établissement public, des désordres persistants ou dégradations peuvent conduire à une sortie disciplinaire après avertissement et accord médical; l'urgence et les soins sans consentement imposent des limites. Le paiement dépend du cadre: honoraires en libéral, prestations en clinique, régime légal à l'hôpital public; seuls les actes réellement réalisés sont facturables. L'assurance maladie prend en charge une partie des frais.

La loi du 9 juillet 2025 renforce la protection pénale des professionnels de santé, y compris en exercice libéral pour l'outrage. L'employeur peut porter plainte avec l'accord écrit du soignant; les ordres professionnels peuvent exercer les droits de la partie civile. Incivilité et infraction ne se confondent pas. Un trouble psychique n'emporte pas automatiquement irresponsabilité pénale: l'abolition ou l'altération du discernement doit être appréciée. L'agressivité du patient ne dispense jamais de ses obligations professionnelles.

Usager Informations utiles et collaboration

Établissement Règlement et sécurité du service

Soignant Protection pénale et obligations de soins

> **À retenir.** Droits du patient et sécurité du soignant doivent être protégés ensemble.

> **Nuance du support (p. 6) :**
> En exercice libéral, les honoraires sont fixés « avec tact et mesure ».

3 Accès, continuité, permanence et handicap

Support officiel, p. 10-12

Le droit fondamental à la protection de la santé est mis en œuvre par les moyens disponibles: prévention, égal accès aux soins nécessaires, continuité et sécurité sanitaire. Professionnels, établissements, assurance maladie, autorités sanitaires, collectivités et usagers y contribuent dans leur champ de compétence. L'accès comporte des dimensions financières, territoriales et organisationnelles; la médiation sanitaire et linguistique facilite l'accès effectif. La protection de la santé possède aussi une valeur constitutionnelle, rattachée au onzième alinéa du Préambule de 1946; les limitations d'autres libertés doivent rester encadrées et proportionnées.

La continuité évite les ruptures du parcours: transmission utile, coordination, relais et suivi des résultats doivent être organisés. Le dossier médical partagé peut y contribuer, dans le respect des droits d'accès et du secret. La permanence vise la possibilité d'obtenir des soins selon l'organisation prévue, y compris hors des horaires usuels; elle ne signifie pas que chaque professionnel est personnellement disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent une formation initiale et continue sur le handicap, les connaissances et innovations pertinentes, l'accueil, l'accompagnement et l'annonce du handicap. Adapter l'information et l'environnement participe à l'effectivité des droits.

Accès Pouvoir entrer dans le parcours

Continuité Éviter une rupture entre intervenants

Permanence Organiser une réponse dans le temps

Adaptation Handicap, langue et compréhension

> **À retenir.** Un droit annoncé doit pouvoir être exercé dans le parcours réel du patient.

4 Non-discrimination et refus de prise en charge

Support officiel, p. 13-15

Aucune personne ne doit subir de discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins. Les motifs prohibés du code pénal et la situation de bénéficiaire de la protection complémentaire ou de l'aide médicale de l'État sont concernés. Une discrimination peut prendre la forme d'un refus direct, d'un délai anormal ou d'une orientation systématique injustifiée.

L'usager peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorial de l'ordre concerné. Le professionnel est informé; une convocation peut intervenir dans le mois. Hors récidive, la conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte. Échec ou récidive conduisent à la transmission à la juridiction ordinale; la carence du conseil peut ouvrir une voie de sanction par l'assurance maladie dans les conditions légales. La voie liée à une carence du conseil est elle-même encadrée par le délai de trois mois prévu.

Un refus pour une exigence personnelle ou professionnelle n'est possible que dans le cadre légal, lorsque cette exigence est essentielle et déterminante pour la qualité, la sécurité ou l'efficacité des soins. Il n'est pas opposable en urgence et la continuité doit être assurée. Certaines clauses de conscience sont expressément prévues, notamment en matière d'IVG, d'IMG, de stérilisation, d'aide à mourir ou de recherche sur l'embryon; leurs conditions propres ne doivent pas être généralisées.

Refus constaté Direct ou indirect

Motif à examiner Qualité, sécurité, efficacité ou discrimination

Garanties Urgence et continuité

Recours Assurance maladie ou ordre professionnel

> **À retenir.** Un refus doit être légalement justifié et compatible avec la continuité.

5 Dignité et soins conformes aux connaissances

Support officiel, p. 16-19

La dignité est une valeur intrinsèque de la personne, qui interdit de la réduire à un objet. Elle fonde le respect, la bientraitance et l'attention à la vulnérabilité. L'interdiction des certificats de virginité s'applique même si la personne les demande ou y consent. L'établissement d'un tel certificat est pénalement sanctionné; examens, incitation ou contrainte relèvent également de dispositions pénales, avec aggravations pour les mineurs. Le support cite pour l'établissement du certificat un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Le patient a droit aux soins les plus appropriés, d'efficacité reconnue au regard des connaissances médicales avérées, sans risque disproportionné au bénéfice attendu. La qualité est appréciée à la date des soins, et non avec les seules connaissances acquises après ceux-ci. L'infirmier fonde sa pratique sur les données acquises de la science, actualise ses compétences et n'utilise pas de remèdes illusoires ou insuffisamment éprouvés.

Il s'agit en principe d'une obligation de moyens: mettre en œuvre les soins adaptés, sans promettre un résultat certain. Les recommandations de la Haute Autorité de santé éclairent les pratiques et l'appréciation judiciaire. Le patient ne peut exiger n'importe quel traitement; indication médicale et consentement doivent se rencontrer. Une prescription hors autorisation de mise sur le marché obéit à un cadre spécifique et ne doit pas être assimilée automatiquement à un accès compassionnel.

Personne Dignité inconditionnelle

Connaissances État de la science à la date du soin

Décision Bénéfice attendu et risques

Responsabilité Moyens adaptés, sans résultat garanti

> **À retenir.** Respect de la personne, indication et proportion bénéfice-risque guident les soins.

6 Prévenir, évaluer et soulager la souffrance

Support officiel, p. 20-22

La reconnaissance du soulagement s'est développée par les lois de 1995, 1999, 2002, 2005 et 2016. Le droit porte désormais sur la souffrance, qui dépasse la douleur physique. Elle doit être prévenue, prise en compte, évaluée et traitée en toutes circonstances. Les soins palliatifs et leur accompagnement sont également renforcés par la loi du 26 mai 2026.

L'infirmier soulage par des moyens appropriés, accompagne moralement et agit dans ses compétences propres, sur prescription ou selon un protocole. La prévention se prépare avant un geste potentiellement douloureux. L'évaluation utilise un outil adapté: auto-évaluation si possible, hétéro-évaluation si la personne ne peut communiquer; réévaluation, traçabilité et information sont indispensables.

La persistance d'une douleur ne prouve pas à elle seule une faute. L'absence d'évaluation, un défaut de traçabilité, une réponse inadaptée ou l'absence de recours pertinent à une structure spécialisée peuvent caractériser un manquement. En phase avancée ou terminale, une souffrance réfractaire peut justifier des traitements analgésiques et sédatifs, même s'ils peuvent avoir pour effet d'abréger la vie: l'objectif reste le soulagement.

Avant le soin Prévenir

Pendant Évaluer et adapter

Après Réévaluer et tracer

Si échec Réexaminer et solliciter une aide adaptée

> **À retenir.** Prévenir → évaluer → traiter → réévaluer → tracer.

02 · Fin de vie, souffrance et refus de l'obstination déraisonnable

DROITS, ACCÈS ET PROTECTION

7 Soins palliatifs: une approche globale et précoce

Support officiel, p. 23-26, 34

La fin de vie doit rester digne, accompagnée du meilleur apaisement possible. Toute personne dont l'état le requiert a droit aux soins palliatifs et à un accompagnement. Ils sont actifs, continus, précoces lorsque nécessaires, et ne se réduisent ni aux dernières heures ni à la seule douleur. Ils répondent aux symptômes physiques, aux souffrances psychiques et aux besoins sociaux et spirituels, dans une démarche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.

L'entourage, famille mais aussi proches et amis, bénéficie d'un soutien psychologique et social, y compris après le décès. Les soins peuvent être délivrés à domicile, en établissement, en EHPAD et dans les lieux de privation de liberté. La loi du 26 mai 2026 prévoit notamment une organisation territoriale pilotée par les agences régionales de santé, une stratégie nationale et un plan personnalisé d'accompagnement proposé après un diagnostic grave, une aggravation chronique ou un début de perte d'autonomie. L'organisation comprend des structures spécialisées et un référent coordonnant l'accès dans les établissements concernés, avec les conditions de bénévolat et d'absence de dépassement prévues pour ces missions; l'instance nationale remet un rapport biennal au Parlement.

L'anticipation comprend l'information sur les directives anticipées et la personne de confiance; elle n'oblige pas le patient à les rédiger ou à désigner quelqu'un. L'infirmier facilite l'accès aux soins palliatifs, accompagne le mourant et réconforte ses proches. Les bénévoles formés, sélectionnés par une association, interviennent avec l'accord requis et dans un cadre conventionnel, sans se substituer aux professionnels ni pratiquer leurs soins; discrétion, confidentialité et respect des convictions s'imposent.

Physique Douleur et autres symptômes

Psychique Souffrance et accompagnement

Social et spirituel Besoins, liens et convictions

Entourage Soutien avant et après le décès

> **À retenir.** Prendre soin de la personne dans toutes ses dimensions, et soutenir son entourage.

8 Refuser l'obstination déraisonnable

Support officiel, p. 27-29

Un acte ne doit pas être entrepris ou poursuivi s'il est inutile, disproportionné ou n'a d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. La nutrition et l'hydratation artificielles sont des traitements; leur éventuel arrêt ne dispense jamais des soins de confort et de l'accompagnement. La décision recherche la volonté du patient, et non seulement l'avis de l'équipe ou des proches.

Si la personne peut s'exprimer, sa volonté éclairée est recherchée. Si elle ne le peut pas, les directives anticipées sont recherchées en premier; à défaut, le témoignage de la personne de confiance, puis de la famille ou des proches, permet de connaître sa volonté. La personne de confiance témoigne, elle ne décide pas à la place du patient.

Une limitation ou un arrêt de traitement chez une personne hors d'état d'exprimer sa volonté relève d'une procédure collégiale. L'équipe de soins participe à la concertation; le cadre applicable prévoit une concertation pluridisciplinaire et les avis médicaux requis. Le médecin responsable prend la décision, la motive et la trace au dossier; les personnes concernées sont informées. Les directives ne peuvent être écartées arbitrairement. Les décisions Lambert et les contrôles constitutionnels éclairent ces garanties.

Patient capable Volonté actuelle

Patient incapable de s'exprimer

Directives puis témoignages

Concertation Équipe et avis requis

Décision Médecin, motivation et traçabilité

> **À retenir.** Rechercher la volonté du patient avant de décider de limiter ou d'arrêter un traitement.

9 Sédation profonde et continue jusqu'au décès

Support officiel, p. 30-31

La sédation profonde et continue jusqu'au décès provoque une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et, dans le cadre légal, à l'arrêt des traitements de maintien en vie. Elle est différente d'une sédation proportionnée, transitoire, ajustée à un symptôme. Sa finalité est le soulagement, et non l'administration d'une substance destinée à provoquer la mort.

À la demande du patient atteint d'une affection grave et incurable, deux situations sont distinguées: un pronostic vital engagé à court terme avec souffrance réfractaire; ou une décision d'arrêter un traitement qui engage le pronostic vital à court terme et risque d'entraîner une souffrance insupportable. Il ne faut pas fusionner ces conditions. Pour un patient hors d'état d'exprimer sa volonté, l'arrêt d'un traitement de maintien en vie au titre de l'obstination déraisonnable conduit au dispositif de sédation prévu, sous réserve de sa volonté antérieure, notamment d'une opposition exprimée.

La procédure collégiale vérifie préalablement les conditions. La mise en œuvre peut avoir lieu à domicile, en établissement de santé ou en établissement médico-social selon les conditions légales et organisationnelles. L'analgésie, l'accompagnement et la traçabilité restent nécessaires.

Cas 1 Affection grave et incurable, court terme, souffrance réfractaire

Cas 2 Arrêt de traitement, court terme, souffrance insupportable

Patient non communicant Arrêt au titre de l'obstination déraisonnable

Garanties Vérification collégiale, analgésie et accompagnement

> **À retenir.** Condition médicale + volonté + procédure: aucun automatisme fondé sur le seul âge.

10 Aide à mourir: un cadre distinct

Support officiel, p. 32-33

Le support expose la loi du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir, après une adoption définitive le 15 juillet et une décision constitutionnelle du 14 août. Cette aide implique le recours à une substance létale. Le principe est l'auto-administration; l'administration par un médecin ou un infirmier n'est prévue que si la personne n'est pas physiquement en mesure de l'effectuer. Il faut distinguer le texte promulgué, ses conditions et l'effectivité liée aux dispositions d'application: aucune disponibilité pratique n'est présumée ici.

Les cinq conditions sont cumulatives: avoir au moins dix-huit ans; être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière; avoir une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale; présenter une souffrance liée à cette affection, réfractaire aux traitements, ou insupportable lorsque la personne a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter un traitement; être apte à manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance psychologique seule est exclue. L'accord d'un proche ne remplace pas la volonté personnelle requise.

Un majeur protégé n'est pas présumé incapable du seul fait de sa mesure. Le protecteur est associé selon le cadre légal, ses observations sont prises en compte et un recours particulier est prévu. L'oral évoque un délai de réflexion de deux jours: il ne doit pas devenir une promesse de réalisation en quarante-huit heures. La sédation profonde et continue et l'aide à mourir obéissent à des finalités, conditions, procédures et clauses de conscience distinctes. Les délais et décrets d'application doivent être revérifiés avant toute utilisation opérationnelle. Le texte prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision; au-delà de trois mois avant confirmation, le caractère libre et éclairé de la volonté est à nouveau évalué. Le protecteur dispose, dans les cas prévus, d'un recours de deux jours devant le juge administratif contre l'autorisation.

Soins palliatifs Soulager et accompagner

Sédation profonde Altérer la conscience pour soulager dans les cas légaux

Aide à mourir Recours à une substance létale dans un cadre propre

> **Note de cours.** Point de vigilance Conditions cumulatives et application à vérifier

> **À retenir.** Distinguer sédation, soins palliatifs et aide à mourir.

FIN DE VIE: DISTINGUER LES CADRES

03 · Choix, secret et partage d'informations

11 Libre choix et limites pratiques

Support officiel, p. 35-36

Le patient choisit librement son praticien, son établissement et son mode de prise en charge, ambulatoire ou à domicile. Ce principe fondamental vaut notamment pour l'accompagnement palliatif. Le médecin doit respecter le choix de la personne.

Le choix rencontre des limites légales: capacités techniques, mode de tarification et meilleure sécurité possible. Le parcours de soins coordonnés peut influer sur le remboursement, sans faire disparaître le principe du libre choix. Il ne faut pas convertir les pourcentages cités à l'oral en règles universelles: remboursement, actes et situations dérogatoires varient.

L'urgence, l'organisation d'un service public, les soins psychiatriques sans consentement ou une détention peuvent encadrer les modalités concrètes d'exercice du choix. Même sous une mesure psychiatrique, la personne conserve le droit de prendre conseil d'un praticien de son choix dans les limites légales.

Principe Choisir praticien, établissement et mode de soins

Organisation Capacités et urgence

Financement Tarification et parcours

Situation particulière Mesure psychiatrique ou détention

> **À retenir.** Libre choix ne signifie ni disponibilité illimitée ni remboursement identique.

12 Vie privée et secret professionnel

Support officiel, p. 37-38

Le patient a droit au respect de sa vie privée et des informations qui le concernent. L'intimité, la pudeur, les visites, les convictions et l'image doivent être respectées. Une photographie n'est pas un geste anodin: l'accord et le cadre approprié sont nécessaires. Le secret couvre ce qui est confié, mais aussi ce qui est vu, entendu ou compris pendant la prise en charge.

Tous les professionnels, personnels et étudiants sont concernés. L'infirmier est tenu au secret professionnel. Obtenir ou tenter d'obtenir illégalement une information et révéler un secret sont deux comportements distincts,

sanctionnés par des textes distincts. L'article 226-13 du code pénal réprime la révélation par un dépositaire du secret; le support mentionne un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

La confidentialité exige aussi une organisation concrète: fermer une session, protéger les documents, éviter les échanges dans des lieux où ils sont entendus. Une imprudence peut constituer un manquement de sécurité; il ne faut pas assimiler automatiquement toute négligence à la qualification pénale intentionnelle de révélation du secret. Le secret contribue à la confiance et à l'accès aux soins.

Ce qui est dit Confidences

Ce qui est observé Faits vus ou entendus

Ce qui est compris Déductions relatives à la personne

Protection Accès justifié et sécurisation

> **À retenir.** Le secret protège toutes les informations apprises dans le cadre de la prise en charge.

13 Échanger et partager au sein du parcours

Support officiel, p. 39

L'échange ou le partage ne devient pas libre parce que deux personnes travaillent dans le même établissement. Les professionnels doivent participer à la prise en charge, ne recevoir que ce qui est strictement nécessaire à la coordination, à

la continuité, à la prévention ou au suivi, et rester dans leurs missions.

Au sein d'une même équipe de soins, les informations nécessaires sont réputées confiées à l'ensemble de l'équipe. Le patient doit être informé de ses droits et peut s'opposer à l'échange ou au partage dans le cadre légal. Entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe, le partage d'informations nécessaires requiert le consentement préalable du patient. La phrase générale sur le consentement ne doit donc pas effacer la distinction entre équipe et hors équipe.

L'équipe de soins peut résulter d'un exercice commun dans une structure, d'une reconnaissance par le patient dans le parcours prescrit, ou d'une organisation formalisée conforme aux conditions légales. L'appartenance à l'équipe n'autorise jamais la consultation par curiosité. Le dossier médical partagé possède aussi ses règles propres d'accès et de consentement.

Équipe de soins Informations nécessaires réputées confiées

Hors équipe Consentement préalable au partage

Dans tous les cas Nécessité, missions et information du patient

> **À retenir.** Même patient pris en charge + nécessité + mission + cadre de partage.

14 Proches, décès et information génétique

Support officiel, p. 40-42

La famille n'est pas destinataire automatique d'informations médicales. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le médecin peut délivrer à la famille, aux proches ou à la personne de confiance les informations nécessaires au soutien direct, sauf opposition du patient. Le périmètre du soutien ne donne pas accès à l'ensemble du dossier.

Après le décès, les ayants droit, le concubin ou le partenaire de PACS peuvent recevoir les informations strictement nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf opposition antérieure. Pour un mineur décédé, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès, sous réserve des soins pour lesquels le secret avait été légalement demandé.

Avant un examen génétique, la personne est informée des risques qu'un silence ferait courir à sa famille si une anomalie grave accessible à une prévention ou à des soins est découverte. Les modalités sont préparées par écrit. Le patient peut informer les apparentés ou demander par écrit une information par le médecin, sans révélation de son identité ni détail de l'anomalie dans le message initial. Le médecin de génétique consulté reçoit ensuite les éléments utiles. Des dispositifs particuliers concernent le tiers donneur, les personnes issues d'un don et, via le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, les naissances sous le secret.

Patient vivant Soutien des proches dans le cadre légal

Après décès Trois finalités, informations nécessaires

Génétique Circuit d'information encadré

Origines Intermédiaires spécialisés, sans divulgation indue

> **À retenir.** Le secret perdure après le décès; les accès sont finalisés et limités.

15 Dérogations au secret et signalement

Support officiel, p. 43

Le secret n'est levé que par un fondement légal et dans son périmètre. Des déclarations sont imposées, notamment naissances, décès et maladies soumises à déclaration obligatoire. Les modalités de transmission des maladies ne peuvent pas être résumées à une anonymisation identique pour toutes: les circuits de signalement et de surveillance doivent être respectés.

L'article 226-14 du code pénal autorise certains signalements. Pour un mineur ou une personne qui ne peut se protéger, l'accord n'est pas requis dans les cas prévus; les obligations de dénonciation ou de protection doivent aussi être examinées. Pour un majeur victime de violences, le signalement par un professionnel de santé se fait en principe avec son

accord dans le cadre applicable. Les violences conjugales peuvent permettre un signalement sans accord lorsque les critères légaux de danger immédiat et d'emprise sont réunis.

Une information préoccupante concernant un mineur relève de la cellule de recueil des informations préoccupantes du département, selon la situation; l'urgence et le danger peuvent appeler d'autres autorités compétentes. Un signalement de bonne foi dans le cadre légal bénéficie d'une protection. Ne transmettre que les informations utiles et tracer la démarche. Le secret ne doit ni servir de prétexte à l'inaction ni être abandonné pour toute inquiétude.

Repérer Danger et vulnérabilité

Qualifier Dérogation ou obligation légale

Transmettre Autorité compétente, contenu nécessaire

Tracer Éléments factuels et démarche

> **À retenir.** Identifier le texte, la situation, le destinataire et les informations nécessaires.

CHOIX, SECRET ET PARTAGE

04 · Information, consentement et volonté du patient

16 Information collective et transparence des coûts

Support officiel, p. 45, 47-48

Un service public diffuse gratuitement et largement l'information en santé, notamment par Santé.fr, dans une forme accessible aux personnes handicapées. Le livret d'accueil présente l'établissement; la certification et les indicateurs de qualité et de sécurité sont rendus publics par la Haute Autorité de santé.

Le patient reçoit une information sur les tarifs et les frais. À la sortie, un document présente le coût des prestations, la part de l'assurance maladie obligatoire, celle de l'organisme complémentaire et le reste à acquitter. Les libéraux et centres de santé affichent les tarifs; un devis préalable est requis dans certaines situations. Les établissements et les sociétés de téléconsultation ont des obligations d'affichage et d'information adaptées à leur activité.

La personne doit aussi pouvoir connaître le respect des conditions légales d'exercice et de l'obligation d'assurance de responsabilité du professionnel ou de l'organisme concerné. Cette transparence facilite le choix mais ne remplace pas l'information individuelle sur l'état de santé et les actes proposés.

Offre de soins Accueil et accès

Qualité Certification et indicateurs

Coût Parts prises en charge et reste à payer

Professionnel Exercice légal et assurance

> **À retenir.** Information sur l'offre, la qualité, les coûts et les conditions d'exercice.

17 Informer sur la santé et les actes proposés

Support officiel, p. 46, 49-51

Toute personne a droit à une information sur son état de santé. Elle porte sur l'utilité, l'urgence éventuelle et les conséquences des actes proposés, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions et les conséquences d'un refus. Un risque grave n'a pas à être fréquent pour être expliqué; un risque fréquent n'a pas à être grave. Les risques nouveaux connus après les soins doivent être communiqués sauf impossibilité de retrouver la personne.

Chaque professionnel informe dans son champ de compétence: l'infirmier sur les soins infirmiers, le médecin sur diagnostic et pronostic. L'entretien individuel délivre une information loyale, claire et adaptée. Un document écrit complète l'oral sans le remplacer; une signature ne prouve pas à elle seule la qualité de l'entretien. Seules l'urgence ou l'impossibilité peuvent dispenser d'informer au moment considéré; l'information reprend dès que possible.

Le souhait de ne pas connaître un diagnostic ou un pronostic doit être respecté, sauf risque de transmission pour des tiers. Il ne supprime pas la nécessité d'une information sur les actes pour consentir. La preuve de l'information appartient au professionnel ou à l'établissement et peut être rapportée par tout moyen. Un défaut peut entraîner une perte de chance ou un préjudice d'impréparation, même sans perte de chance selon les conditions de réparation.

Proposition Utilité, urgence, conséquences

Choix Alternatives et conséquences du refus

Risques Fréquents ou graves prévisibles

Preuve Traçabilité, sans formulaire magique

> **À retenir.** Informer pour permettre une décision; adapter et tracer l'échange.

18 Information du mineur et du majeur protégé

Support officiel, p. 52-54

Pour le mineur, les titulaires de l'autorité parentale exercent en principe les droits d'information, mais le mineur reçoit lui-même une information adaptée à sa maturité et participe à la décision. Son consentement est recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté. Le mineur émancipé relève des règles qui lui permettent de décider personnellement, sous réserve des régimes particuliers.

La personne majeure protégée reste destinataire de l'information, adaptée à ses facultés de discernement. Une mesure de protection ne suffit pas à considérer qu'elle ne comprend pas. En présence d'une représentation relative à la personne, l'information est aussi délivrée au protecteur; elle s'ajoute à celle du majeur sans la remplacer.

Il faut lire le jugement: assistance ou représentation, biens ou personne, étendue exacte de la mission. En curatelle, sauvegarde ou mesure limitée aux biens, le protecteur n'est pas automatiquement destinataire des informations de santé; l'accord de la personne est nécessaire hors autre fondement légal. L'autonomie

s'apprécie pour la décision concrète, pas à partir d'une étiquette générale de tutelle.

Mineur Parents + information adaptée de l'enfant

Majeur protégé Information directe adaptée

Représentation à la personne

Protecteur également informé

Autres mesures Pas d'accès automatique du protecteur

> **À retenir.** Informer la personne concernée avant de raisonner sur son représentant.

19 Consentement: caractères et enseignement clinique

Support officiel, p. 55-56

La décision concernant la santé est prise avec le professionnel à partir de ses informations et préconisations. Aucun acte ni traitement ne se pratique sans consentement libre et éclairé, sous réserve des exceptions légales. Le consentement est préalable, spécifique à l'acte et révocable à tout moment. L'absence de protestation ne constitue pas, à elle seule, la preuve d'un choix libre.

Libre signifie sans pression ni contrainte des soignants ou des proches. Éclairé suppose une information comprise et adaptée. Une autorisation générale pour toute prise en charge ne dispense pas de rechercher le choix concernant les actes. Le consentement est en principe oral; certains domaines imposent une forme écrite, notamment recherche, assistance médicale à la procréation, certains dons ou stérilisation. Sa recherche et son recueil doivent être tracés.

Un consentement spécifique est requis pour un enseignement clinique. La présence d'un étudiant ne se déduit pas automatiquement de l'accord donné aux soins. L'information doit distinguer le soin, la participation éventuelle à un enseignement et les usages d'images.

Information Comprendre le choix

Liberté Décider sans pression

Acte déterminé Consentir avant le geste

Dans le temps Pouvoir retirer son accord

> **À retenir.** Libre + éclairé + préalable + spécifique + révocable.

20 Refus de soins et patient qui ne peut s'exprimer

Support officiel, p. 57-59

Toute personne peut refuser ou ne pas recevoir un traitement. Le médecin explique les conséquences et leur gravité, respecte la volonté et poursuit le suivi, notamment palliatif. Si le refus met la vie en danger, la personne réitère sa décision dans un délai raisonnable; un autre médecin peut être sollicité et toute la procédure est tracée. Refus ne signifie ni abandon ni disparition des soins acceptés.

Chez une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un proche est consulté avant une intervention ou investigation, sauf urgence ou impossibilité. Consulter les proches ne leur transfère pas automatiquement le pouvoir de consentir à la place de l'adulte. L'urgence permet d'agir lorsque l'état rend l'intervention nécessaire dans le cadre légal.

Pour une limitation ou un arrêt de traitement, directives anticipées, recherche de la volonté et procédure collégiale suivent leur régime propre. L'histoire jurisprudentielle des transfusions chez un patient refusant les produits sanguins ne doit pas être convertie en droit général de passer outre un refus éclairé. Les pages 58 et 59 du support reprennent la même notion: elle est traitée ici une seule fois sans perte de contenu.

Personne capable Décision et refus éclairé

Refus mettant la vie en danger

Information et réitération

Personne non communicante

Recherche de volonté et consultation

Urgence ou impossibilité Exception encadrée, puis information

> **À retenir.** Informer, rechercher la volonté et assurer la continuité de l'accompagnement.

21 Directives anticipées et personne de confiance

Support officiel, p. 60-61

Toute personne majeure peut rédiger des directives pour le moment où elle ne pourra plus exprimer sa volonté: poursuite, limitation, arrêt ou refus des traitements et actes en fin de vie. L'écrit est daté et signé selon les formes prévues, sur papier libre ou modèle. Depuis 2016, il n'y a plus de limite de trois ans; les directives sont révisables et révocables à tout moment. Elles s'imposent au médecin, sauf urgence vitale pendant le temps nécessaire à l'évaluation ou caractère manifestement inapproprié ou non conforme à la situation, constaté selon la procédure collégiale.

La personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. La désignation est écrite et cosignée, révisable et révocable. Elle est proposée lors d'une hospitalisation. Si le patient le souhaite, elle l'accompagne et assiste aux entretiens; s'il ne peut s'exprimer, elle rend compte de sa volonté et son témoignage prévaut sur les autres témoignages. Elle ne devient pas décideur médical.

Directives anticipées : pour une mesure de protection relative à la personne, L.1111-11 CSP renvoie à l'art. 458 du Code civil : le protecteur ne les rédige pas à la place du majeur.
Personne de confiance : sous représentation relative à la personne, sa désignation exige l'autorisation du juge ou du conseil de famille (L.1111-6 CSP). Ne pas confondre les régimes.

Directives Expression écrite personnelle

Personne de confiance Accompagnement et témoignage

Personne à prévenir Contact pratique

Protecteur Mission définie par le jugement

> **À retenir.** Écrit du patient d'abord; à défaut, témoignage privilégié de la personne de confiance.

INFORMER, CONSENTIR, RECHERCHER LA VOLONTÉ

05 · Mineurs, majeurs protégés et autonomie

22 Mineur: actes usuels, refus et urgence

Support officiel, p. 62-64

Les parents exercent l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant. Pour un acte usuel, un parent est présumé agir avec l'accord de l'autre à l'égard d'un tiers de bonne foi. Cette présomption disparaît si le professionnel connaît l'opposition de l'autre parent. Un acte grave, inhabituel ou engageant durablement la santé relève des actes non usuels et requiert l'accord des deux titulaires dans le cadre applicable.

Les soins courants et le suivi habituel illustrent les actes usuels; chirurgie sous anesthésie générale ou traitement lourd illustrent les actes non usuels. Ce sont des repères, pas une liste automatique: la situation, les risques et les textes particuliers comptent. L'enfant est associé et son consentement est systématiquement recherché selon sa capacité. Le mineur émancipé dispose d'une autonomie spécifique.

Si le refus parental risque d'avoir des conséquences graves sur la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables. Hors urgence, une impossibilité d'obtenir l'autorisation ne justifie pas une intervention quelconque: les voies de protection et, si nécessaire, le procureur sont mobilisés. En urgence, le médecin agit dans l'intérêt de l'enfant et informe les parents dès que possible. Une autorisation anticipée ne dispense pas de l'information et de la prise en compte de la situation réelle.

Usuel Présomption d'accord du second parent

Non usuel Accord des titulaires requis

Refus dangereux Soins indispensables

Urgence Agir dans l'intérêt de l'enfant et informer

> **À retenir.** Intérêt de l'enfant, participation du mineur et cadre de l'autorité parentale.

23 Mineur: secret et décisions personnelles

Support officiel, p. 65

Dans certaines situations, le mineur peut demander que ses parents ne soient pas consultés. Pour le médecin ou la sage-femme, l'article L. 1111-5 encadre la sauvegarde de la santé. Pour l'infirmier, l'article L. 1111-5-1 vise spécifiquement la santé sexuelle et reproductive: cette exception ne s'étend pas à tous les soins infirmiers. Le professionnel cherche d'abord à obtenir l'accord du mineur à la consultation des parents; si l'opposition persiste dans le cadre prévu, le mineur est accompagné par un majeur de son choix.

La contraception et l'interruption volontaire de grossesse disposent de règles propres permettant des décisions confidentielles du mineur. Le secret demandé doit être pris en compte lors de l'accès parental au dossier. L'accompagnant majeur n'est pas un titulaire de l'autorité parentale et sa présence ne le rend pas décideur.

Certains refus du mineur sont opposables: il ne peut être passé outre à son refus de participer à une recherche impliquant la personne humaine; le prélèvement de cellules hématopoïétiques dans le cadre légal du don entre proches comporte aussi des garanties et le refus du mineur y fait obstacle. Ne pas appliquer à ces situations la règle ordinaire de décision parentale.

D'abord Rechercher l'accord à la consultation des parents

Si opposition maintenue Vérifier le cadre légal spécifique

Accompagnement Majeur choisi par le mineur

Refus protégé Recherche et prélèvement encadré

> **À retenir.** Une exception au consentement parental doit toujours être rattachée à son texte.

24 Majeur protégé: autonomie, assistance et représentation

Support officiel, p. 66-69

La réforme du 11 mars 2020, entrée en vigueur le 1er octobre 2020, privilégie l'autonomie plutôt qu'une incapacité déduite du seul statut. La sauvegarde de justice est une mesure en principe temporaire; la curatelle relève de l'assistance; la tutelle peut organiser une représentation. En santé, la personne prend elle-même la décision dans la mesure où son état le permet. Le jugement et la capacité concrète sont donc examinés avant de solliciter un protecteur.

Une représentation relative à la personne n'empêche pas le majeur de consentir s'il en est capable, avec une assistance si besoin. S'il ne peut exprimer un consentement éclairé, le protecteur autorisé intervient en tenant compte de l'avis exprimé. En désaccord, sauf urgence, le juge peut autoriser l'un ou l'autre à décider. Si un refus du protecteur expose à des conséquences graves, les soins indispensables peuvent être délivrés; l'urgence impose d'agir selon le cadre légal.

Attention à une formulation des pages 68-69: l'article 459 actuel permet d'organiser une représentation incluant des actes portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle. Il n'impose pas une autorisation judiciaire nouvelle pour chacun de ces actes du seul fait de leur gravité. Une autorisation spécifique demeure pour les décisions portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée, sous réserve de l'urgence; les régimes spéciaux et le jugement doivent être respectés.

Capacité suffisante Décision par la personne

Besoin de soutien Assistance adaptée

Incapacité à consentir Représentation autorisée et avis recherché

Désaccord Juge hors urgence

> **À retenir.** Évaluer la personne, puis lire l'étendue de la mesure: assister avant de représenter.

25 Actes personnels et régimes de protection spécifiques

Support officiel, p. 70

Les actes strictement personnels ne donnent pas lieu à assistance ou représentation dans les conditions de l'article 458 du code civil. En santé, contraception et IVG relèvent de la décision personnelle; directives, personne de confiance et aide à mourir obéissent à leurs règles particulières. La protection juridique n'est pas un blanc-seing donné à un tiers sur le corps de la personne.

La stérilisation à visée contraceptive d'une personne dont l'altération des facultés mentales a justifié une tutelle ou une curatelle n'est possible que dans les situations restrictives prévues: contre-indication médicale absolue à la contraception ou impossibilité avérée de mise en œuvre efficace. Le juge intervient, et le refus de la personne fait obstacle. Les recherches sont limitées à des conditions protectrices; la volonté est recherchée et le refus respecté.

Le don d'organes du vivant est interdit sur une personne mineure ou majeure bénéficiant d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne. Il ne faut pas étendre cette interdiction à toute mesure limitée aux biens. Tissus, cellules et don du sang obéissent à des textes propres et à des interdictions ou exceptions strictement encadrées; l'accord du protecteur ne suffit pas à créer une possibilité de don.

Acte personnel Pas de substitution automatique

Stérilisation Conditions strictes, juge, refus opposable

Recherche Protection et respect du refus

Don Texte spécifique selon l'acte et la mesure

> **À retenir.** Identifier le régime propre à chaque acte avant toute conclusion.

MINEUR ET MAJEUR PROTÉGÉ

06 · Soins psychiatriques: conditions et garanties

26 Psychiatrie: soins libres et formes de prise en charge

Support officiel, p. 71

Les soins psychiatriques libres sont le principe. Les soins sans consentement ne sont possibles que dans les cas prévus par la loi, organisée notamment par les lois de 2011 et 2013 après le contrôle constitutionnel. Ils n'enlèvent pas l'ensemble des droits du patient et ne se déduisent pas du seul diagnostic psychiatrique.

Deux autorités principales interviennent: le directeur de l'établissement pour les admissions à la demande d'un tiers ou en péril imminent; le représentant de l'État pour les situations concernant la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public. Les conditions de ces deux voies ne sont pas interchangeables.

Deux formes sont possibles dans le cadre légal: hospitalisation complète ou programme de soins, comprenant notamment ambulatoire, domicile ou hospitalisation partielle. Le programme ne doit pas être confondu avec une possibilité générale d'exécuter des soins de force à domicile. Le maintien, le changement de forme et la levée doivent être régulièrement appréciés.

Règle Soins libres

Directeur Tiers ou péril imminent

Préfet Sûreté ou ordre public grave

Forme Hospitalisation complète ou programme

> **À retenir.** Un diagnostic psychiatrique n'abolit ni les droits ni le principe des soins libres.

27 Admission par le directeur: tiers, urgence et péril imminent

Support officiel, p. 72

Deux conditions cumulatives fondent la voie du directeur: les troubles rendent impossible le consentement; l'état impose des soins immédiats avec une surveillance médicale constante ou régulière. La seule difficulté relationnelle ou un refus compréhensible ne suffit pas.

À la demande d'un tiers, celui-ci peut être un membre de la famille ou une personne ayant des relations antérieures lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de la personne. Deux certificats circonstanciés sont normalement requis, dont le premier établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. En

urgence, avec risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, une procédure à un certificat est possible selon l'article L. 3212-3.

Le péril imminent permet une admission sans demande de tiers lorsqu'il est impossible d'en obtenir une et qu'un péril imminent pour la santé est constaté. Le certificat initial est établi par un médecin extérieur à l'établissement. Tiers en urgence et péril imminent sans tiers sont deux procédures distinctes, avec des exigences propres.

Conditions Consentement impossible + soins immédiats

SDT Tiers et deux certificats

Urgence avec tiers Risque grave et cadre à un certificat

Péril imminent Sans demande de tiers, certificat extérieur

> **À retenir.** Conditions cliniques cumulatives, puis identification de la procédure adaptée.

28 Admission par le préfet et danger imminent

Support officiel, p. 73

Le représentant de l'État peut prononcer une admission si les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. L'arrêté est motivé et précise les circonstances. Un certificat médical circonstancié est nécessaire.

Le support présente ce certificat comme émanant d'un psychiatre extérieur. Le texte de l'article L. 3213-1 dit qu'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil: il ne réserve pas sa rédaction aux seuls psychiatres extérieurs. Cette différence doit être préservée dans les QCM.

En danger imminent, le maire peut prendre des mesures provisoires selon les conditions légales et en réfère au préfet; leur maintien au-delà de quarante-huit heures nécessite la décision prévue. Les personnes déclarées pénalement irresponsables peuvent relever de voies particulières par décision préfectorale ou judiciaire. La procédure spécifique ne doit pas être assimilée à une sanction disciplinaire hospitalière.

Fondement Troubles nécessitant des soins

Risque Sûreté ou ordre public grave

Décision Arrêté motivé du préfet

Danger imminent Mesure provisoire du maire, relais préfectoral

> **À retenir.** Soins nécessaires + sûreté compromise ou atteinte grave à l'ordre public.

29 Chronologie des soins sans consentement

Support officiel, p. 74-75

À l'admission débute une période initiale d'observation et de soins en hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures, un médecin réalise un examen somatique complet et un psychiatre établit un certificat sur le maintien nécessaire ou non des soins. Dans les soixante-douze heures, un nouveau certificat psychiatrique est établi; si le maintien est nécessaire, il propose la forme de prise en charge.

La décision sur la forme est prise par l'autorité compétente. Le patient reçoit l'information adaptée et ses observations sont recueillies. Le schéma distingue les évaluations médicales des contrôles judiciaires: hospitalisation complète contrôlée avant l'expiration du douzième jour, avec saisine au plus tard au huitième jour selon le cadre applicable, puis contrôle tous les six mois en cas d'hospitalisation complète continue.

Des certificats périodiques accompagnent le suivi; ils sont notamment mensuels dans la voie du directeur. L'audience comporte l'assistance ou la représentation par un avocat selon les règles applicables; elle se tient en principe dans le cadre hospitalier organisé. Une saisine peut intervenir à tout moment par les personnes habilitées. La mesure peut être levée lorsqu'elle n'est plus justifiée. Les textes actuels visent le magistrat du siège du tribunal judiciaire; l'appellation JLD utilisée dans le support correspond à la terminologie antérieure de ce contrôle.

J0 Admission et observation

24 h Examen somatique + certificat psychiatrique

72 h Nouveau certificat et proposition de forme

Avant J12 Contrôle du juge

Ensuite Suivi et contrôle semestriel

> **À retenir.** 24 h et 72 h: évaluations; 12e jour et six mois: contrôle judiciaire.

Soins psychiatriques: chronologie de l'admission au contrôle **Voir l'infographie p. 32**

30 Isolement et contention: conditions et durées

Support officiel, p. 75-77

Isolement et contention sont des pratiques de dernier recours, réservées à l'hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient ou à autrui. La décision motivée d'un psychiatre doit être adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation. La contention mécanique s'inscrit dans une mesure d'isolement. Il

ne s'agit jamais d'une sanction ou d'une facilité d'organisation.

L'isolement est décidé pour douze heures au maximum; les renouvellements évalués sont possibles dans la limite totale de quarante-huit heures selon le cadre ordinaire. La contention est limitée initialement à six heures, pour un total ordinaire de vingt-quatre heures. Les évaluations sont au moins deux par vingt-quatre heures pour l'isolement et deux par douze heures pour la contention. Une surveillance stricte somatique et psychiatrique est organisée et tracée.

Au-delà de ces durées totales, le renouvellement est exceptionnel et le tribunal est informé sans délai. Si la poursuite au-delà de soixante-douze heures d'isolement ou quarante-huit heures de contention est nécessaire, le directeur saisit le juge avant ces échéances. Le juge statue dans les vingt-quatre heures à compter de leur terme, non simplement dans les vingt-quatre heures de n'importe quelle saisine. Les règles de cumul, de renouvellements successifs et d'information des proches doivent être respectées; les délais ne se remettent pas à zéro par un fractionnement artificiel.

Isolement 12 h initiales; 48 h au total ordinaire

Contention 6 h initiales; 24 h au total ordinaire

Au-delà Renouvellement exceptionnel et tribunal informé

Saisine Avant 72 h d'isolement ou 48 h de contention

> **À retenir.** Dernier recours, proportionnalité, décision motivée, surveillance et contrôle judiciaire.

31 Psychiatrie: droits conservés et traçabilité

Support officiel, p. 77-78

Les restrictions de liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental et au traitement requis. L'avis du patient sur les modalités de soins est recherché et pris en considération autant que possible. Une admission sans consentement ne supprime pas la dignité, l'information ni les voies de recours.

La personne peut communiquer avec les autorités compétentes, saisir la commission départementale des soins psychiatriques et signaler des faits au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Elle conserve le droit de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix, d'émettre et recevoir des courriers, de consulter le règlement et d'obtenir des explications, de voter et de pratiquer les activités religieuses ou philosophiques de son choix dans le cadre légal.

L'établissement tient un registre des mesures d'isolement et de contention: psychiatre décideur, identifiant et âge du patient, mode d'hospitalisation, dates, heures, durées et professionnels de surveillance. Un rapport annuel contribue à l'évaluation des pratiques et à leur limitation. Les contrôles de la commission, du Contrôleur général et des autres autorités habilitées ne remplacent pas le contrôle individuel du juge.

Voix du patient Avis recherché et information

Recours Juge, commission et autorités

Vie personnelle Courrier, convictions et vote

Traçabilité Dossier, registre et rapport annuel

> **À retenir.** Conserver les droits et permettre leur exercice malgré la restriction de liberté.

PSYCHIATRIE: CADRES ET GARANTIES

07 · Dossier médical: contenu, accès et délais

32 Dossier médical: contenu, accès et conservation

Support officiel, p. 79-84

La loi du 4 mars 2002 permet l'accès direct aux informations formalisées de santé, ou par l'intermédiaire d'un médecin désigné. Le dossier comprend résultats, comptes rendus, prescriptions, correspondances et dossier de soins infirmiers. Les informations recueillies auprès de tiers extérieurs à la prise en charge ou concernant ces tiers sont exclues de l'accès dans

le cadre prévu. Les notes réellement personnelles ne doivent pas servir à soustraire artificiellement des informations formalisées nécessaires aux soins.

À l'admission et durant le séjour, sont tracés motifs, antécédents, examen clinique, prescriptions, soins, examens, comptes rendus, anesthésie, transfusions et consentements écrits requis. En fin de séjour figurent lettre de liaison, prescriptions et modalités de sortie. Les données sont datées, identifiées, lisibles et objectives; les accès sont limités aux besoins de prise en charge et l'hébergement est sécurisé.

Dans un établissement, la durée de base est de vingt ans après le dernier séjour ou la dernière consultation externe. Si cette échéance précède le vingt-huitième anniversaire, elle est prolongée jusqu'à cette date. Le délai de dix ans après le décès s'applique lorsque le décès survient moins de dix ans après le dernier passage; ce n'est pas une règle uniforme pour tout décès. Un recours en responsabilité suspend les délais concernés.

L'accès intervient après un délai de réflexion de quarante-huit heures et au plus tard dans les huit jours; le délai est de deux mois si les informations ont plus de cinq ans ou dans certaines situations psychiatriques. La consultation sur place est gratuite; le droit d'accès au titre du RGPD prévoit en principe une première copie gratuite, les copies supplémentaires ou demandes manifestement excessives ayant un régime propre. Un accompagnement par un tiers peut être recommandé; son refus n'empêche pas l'accès de droit commun.

Pour le mineur, les parents accèdent sous réserve du secret légalement demandé; le mineur peut demander un intermédiaire médecin. Le majeur protégé conserve son accès; un représentant à la personne peut aussi accéder dans son cadre, les autres protecteurs n'ayant pas d'accès automatique. En soins psychiatriques sans consentement, des risques d'une gravité particulière peuvent exceptionnellement imposer la présence d'un médecin. En refus, la commission départementale est saisie et son avis s'impose; les soins libres suivent le droit commun. Pour un établissement public, la CADA puis le juge administratif constituent une voie de recours.

Constituer Informations utiles et datées

Protéger Accès justifiés et hébergement sécurisé

Communiquer 48 h à 8 jours; exceptions à 2 mois

Conserver 20 ans, prolongations et cas du décès

À retenir. Formaliser pour soigner, protéger et permettre un accès effectif.

DOSSIER MÉDICAL: ACCÈS ET CONSERVATION

08 · Application hospitalière: droits au quotidien et relations avec les usagers

Les situations et dispositifs ci-dessous complètent les principes juridiques précédents, à partir du cours consacré aux droits des usagers en établissement et de ses exemples de terrain. Les modalités propres à l'établissement sont distinguées des règles générales.

Les droits des patients au quotidien

COMPRENDRE LES DROITS POUR LES RENDRE EFFECTIFS

Le patient reste une personne qui décide, comprend, ressent et possède une vie privée. Les droits s'appliquent dans chaque soin, y compris aux gestes ordinaires et aux soins réalisés par un étudiant. L'information, le consentement et le respect de la dignité structurent la relation de soin.

Droit essentiel	Conséquence concrète pour les soins
Accès et choix	Accueillir sans discrimination, adapter l'accès au handicap et orienter vers une prise en charge appropriée. Le libre choix s'exerce dans les limites de l'urgence, des possibilités techniques et de l'organisation.
Qualité et soulagement	Assurer un accueil et des soins de qualité, prendre en compte la douleur, préserver la dignité et accompagner la fin de vie.
Information et décision	Donner une information compréhensible; rechercher un consentement libre et éclairé, respecter le refus et les situations nécessitant un consentement spécifique.
Liberté et respect	Préserver intimité, croyances et vie privée. Le départ reste possible, sous réserve des dispositions légales particulières et après information sur les risques.
Confidentialité et dossier	Protéger les informations; permettre l'accès aux informations de santé selon la qualité du demandeur et les conditions légales.
Expression et recours	Écouter observations et réclamations, expliquer les démarches et permettre la représentation des usagers.

La charte de la personne hospitalisée rappelle aussi le consentement propre à certaines situations, les règles de la recherche et la possibilité de quitter une recherche sans perdre la qualité des soins. Elle est expliquée au patient et disponible dans l'établissement; elle ne remplace pas les textes applicables.

Choix et continuité

Un patient peut exprimer une préférence ou une difficulté avec un soignant. Rechercher une adaptation ou un relais possible; la préférence ne garantit pas le choix de chaque professionnel à toute heure et ne justifie pas l'abandon d'un soin urgent.

Repères juridiques du CSP : L1110-2 (dignité), L1111-2 (information), L1111-4 (consentement).

CRUA, représentants et commission

TROIS RÔLES COMPLÉMENTAIRES À DISTINGUER

Dans l'organisation présentée à l'AP-HP Paris-Saclay, la qualité, la gestion des risques et les droits des patients coopèrent. La chargée des relations avec les usagers et les associations (CRUA), les représentants des usagers (RU) et la commission des usagers (CDU) n'ont pas le même statut ni la même fonction.

Acteur	Statut et fonction	Exemples de missions
CRUA	Professionnelle de l'établissement; coordonne les relations avec les usagers selon l'organisation locale.	Réclamations et remerciements, enquêtes auprès des services, demandes de dossier, satisfaction, associations, médiations et démarches qualité.
RU	Bénévole issu d'une association agréée; représente les usagers, avec désignation par l'ARS.	Porter la parole des patients, proposer des améliorations, participer à la CDU, accompagner un usager en médiation s'il le souhaite.
CDU	Instance présente dans chaque établissement de santé; veille aux droits et à l'amélioration de l'accueil et de la prise en charge.	Examiner les réclamations de son ressort, les réponses et les actions; recommander des améliorations. Elle se réunit au moins une fois par trimestre.

Une coopération tournée vers les actions

La CRUA assure la coordination institutionnelle; le RU apporte le point de vue des usagers. Les retours positifs sont également transmis: reconnaître une prise en charge réussie aide les équipes à identifier ce qui fonctionne. Les réclamations donnent lieu à une analyse et à des mesures suivies, plutôt qu'à une simple réponse formelle.

Les bons contacts

Orienter vers le livret d'accueil, l'affichage de l'établissement et les coordonnées institutionnelles actualisées. Les associations, les bénévoles et les représentants des cultes ont des missions distinctes, encadrées par l'organisation du site.

La CDU comprend notamment le représentant légal de l'établissement, des médiateurs médicaux et non médicaux ainsi que des RU et leurs suppléants. Le rythme de réunions mensuelles de travail décrit à l'oral est local; il ne remplace pas la réunion trimestrielle de la CDU.

Repère: Service Public - commission des usagers. Les effectifs et l'organisation du support sont une photographie locale, non un modèle obligatoire pour tous les hôpitaux.

Réclamation: répondre et améliorer

LA MÉDIATION RÉTABLIT LE DIALOGUE

Accueillir une réclamation commence par écouter et clarifier les faits, sans promesse d'indemnisation ni jugement hâtif. Selon la situation, des explications peuvent être apportées par le service. Une plainte écrite peut être adressée au représentant légal de l'établissement.

Étape	Action et précision
1 · Exprimer	Au responsable du service, oralement ou par écrit selon la situation.
2 · Transmettre	Réclamation écrite au représentant légal de l'établissement.
Réponse locale	Enquête et explications ; coordination avec la CRUA.
Médiation	Saisine directe du médiateur possible ; accompagnement d'un représentant des usagers (RU) si souhaité.
Commission des usagers	La CDU analyse les réclamations et réponses, avec ou sans médiation, et recommande des améliorations.

Médiation: une possibilité, pas un tribunal ni une étape obligatoire avant tout autre recours.

Circuit local expliqué dans le cours

La CRUA accuse réception, recueille les éléments du service et prépare une réponse validée et signée par la direction. La médiation permet de comprendre le vécu du patient, d'apporter des explications et de rechercher l'apaisement. Le RU peut accompagner le patient.

But recherché	Voie à distinguer
Dialogue et qualité	Réclamation à l'établissement, médiation, CDU. La saisine directe du médiateur est possible.
Réparation d'un dommage	Demande indemnitaire et, selon les conditions, CCI/assureur/ONIAM ou juridiction compétente. La CCI rend un avis; ce n'est pas un tribunal.

But recherché	Voie à distinguer
Autre responsabilité	Démarche ordinale pour une question déontologique; police, gendarmerie ou procureur pour une infraction. Un litige avec un hôpital public peut relever du tribunal administratif.

Ces voies ont des objets différents; ce schéma n'est pas une succession obligatoire avant tout recours. Service Public - CDU.

Informer et vérifier la compréhension

LE PATIENT EST LE PREMIER DESTINATAIRE

L'information doit être loyale, adaptée et intelligible. Elle porte notamment sur le soin proposé, son utilité, son éventuelle urgence, ses conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences d'un refus. Elle se construit dans un entretien permettant les questions.

Situation	Conduite utile
Stress, douleur ou jargon	Choisir un moment et un langage adaptés, expliquer par étapes et laisser du temps. Une absence de question ne prouve pas la compréhension.
Vérifier ce qui est compris	Demander au patient de reformuler avec ses mots ce qu'il a compris et ce qu'il prévoit de faire. Reprendre l'explication sans le mettre en défaut.
Langue ou handicap	Recourir à l'interprétariat et aux aides institutionnelles adaptées: pictogrammes, supports accessibles, moyens de communication. Protéger les données de santé. Ne pas employer d'outil de traduction grand public non autorisé.
Question hors compétence	L'infirmier explique les soins, moyens et techniques relevant de ses compétences. Pour une question qui les dépasse, orienter vers le professionnel légalement compétent et assurer le relais.
Patient mineur ou protégé	Donner aussi une information au patient, adaptée à sa maturité ou à sa capacité de compréhension. La mesure de protection ne le rend pas invisible.

Volonté du patient et exceptions

Respecter la volonté d'une personne de ne pas connaître un diagnostic ou un pronostic, sous réserve du risque de transmission à des tiers prévu par la loi. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser du devoir d'information; apprécier la situation et donner les explications dès que possible. L'urgence n'efface pas systématiquement toute possibilité d'échange.

Exemple de reformulation

« Pour que je vérifie si j'ai été clair, pouvez-vous me dire comment vous allez procéder? » Cette vérification porte sur la qualité de l'explication. Elle évite de confondre un « oui » poli avec une compréhension suffisante.

Consentir et pouvoir refuser

RECHERCHER L'ACCORD AU MOMENT DU GESTE

Un consentement libre et éclairé suppose une information comprise et un choix sans contrainte. Il peut être retiré à tout moment. Un accord donné à l'admission ne dispense pas de rechercher l'accord au soin proposé; l'examen réalisé dans un enseignement clinique requiert aussi le consentement préalable.

Informer	Échanger	Choisir
Le soin, son intérêt, les risques et les possibilités; mots adaptés.	Questions et reformulation: le patient a-t-il compris?	Exprimer un accord libre ou un refus. Aucun accord forcé.

Si accord	Si refus ou retrait
Réaliser le soin consenti, surveiller et rester attentif à la volonté du patient.	Respecter la décision; expliquer, alerter et tracer selon la situation.

La décision peut évoluer: vérifier l'accord au moment du geste, pas uniquement à l'admission.

Point de vigilance	Réflexe professionnel
Peur ou hésitation	Explorer ce qui inquiète, expliquer, répondre et envisager une adaptation. Demander l'accord avant une palpation ou un autre geste.
Refus	Respecter la décision, expliquer les conséquences dans son champ de compétences, alerter le professionnel responsable et tracer. Le suivi et l'accompagnement doivent se poursuivre.
Trace ou formulaire	Tracer l'information et la décision utile. Une signature, le silence ou le seul fait que le geste ait été accompli ne suffisent pas à prouver un consentement valable. Des situations ont des règles écrites spécifiques.

Refus mettant la vie en danger

Le médecin informe des conséquences et de leur gravité; le patient doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Un autre médecin peut être sollicité et la procédure est inscrite au dossier. Ne pas transformer cette discussion en pression pour obtenir un accord.

Schéma: majeur capable d'exprimer sa volonté. Situations de protection ou d'impossibilité: voir les pages dédiées. CSP L1111-4, version en vigueur depuis le 28/05/2026.

Dignité, intimité et qualité des soins

LES DROITS SE VOIENT DANS LES GESTES ORDINAIRES

La dignité ne dépend ni de l'autonomie, ni du comportement, ni du diagnostic. Préserver l'intimité corporelle, la confidentialité des échanges et le respect des convictions demande des gestes concrets, répétés à chaque prise en charge.

Moment du soin	Actions concrètes
Entrer dans une chambre	Frapper, attendre lorsque la situation le permet, se présenter avec sa fonction et un badge lisible. Demander au patient de décliner son identité selon la procédure, plutôt qu'une simple confirmation « Vous êtes M. X? ».
Toilette, examen ou entretien	Fermer la porte, utiliser un paravent et limiter les présences. Expliquer le geste, demander l'accord, couvrir les parties du corps non concernées. Adapter la présence de visiteurs au souhait du patient et aux contraintes du soin.
Transport ou chambre double	Couvrir la personne et tenir compte du voisin. Une porte laissée ouverte à la demande du patient en dehors d'un soin ne dispense pas de réévaluer son intimité pendant le soin.

Moment du soin	Actions concrètes
Douleur	Écouter la plainte, évaluer avec un outil adapté, agir dans le cadre de ses compétences/prescriptions/protocoles et réévaluer. Tracer les observations, les actions et leurs effets.
Repas et autonomie	Vérifier que le plateau, la sonnette et les aides techniques sont accessibles; proposer l'aide nécessaire. Un repas déposé hors de portée ne constitue pas une aide à l'alimentation.
Difficulté, refus ou situation préoccupante	Rechercher un relais ou une discussion d'équipe, sans interrompre un soin urgent. Un étudiant alerte son référent, puis l'encadrement si nécessaire. Protéger le patient et utiliser le circuit de signalement prévu, avec un accès personnel autorisé; ne jamais emprunter les identifiants d'un collègue.

Les convictions du patient sont respectées dans les limites compatibles avec les soins, l'hygiène et la vie collective. Les professionnels assurent leur mission avec neutralité. Négocier une adaptation possible vaut mieux que déduire une règle générale d'une situation isolée.

Point de prudence : les faits observés ne suffisent pas, à eux seuls, à qualifier automatiquement une complicité pénale.

Secret et demandes d'information

VÉRIFIER QUI DEMANDE, POURQUOI ET PAR QUEL CANAL

Le secret couvre les informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel: santé, éléments de vie privée et, selon le contexte, présence dans un établissement. La parenté ou le fait de se présenter comme policier n'ouvrent pas un accès automatique aux informations.

Demande ou situation	Réponse adaptée
Proche sur place ou au téléphone	Vérifier son identité, le souhait du patient et les informations pouvant être transmises. Employer les moyens institutionnels de vérification; ne pas confirmer une présence ni donner des informations sensibles sur la seule déclaration de l'appelant.
Patient capable	Il choisit les personnes qu'il souhaite informer. Personne à prévenir, conjoint ou personne de confiance: aucun de ces titres ne donne, à lui seul, un droit général au dossier.
Diagnostic ou pronostic grave	Le cadre légal permet certaines informations nécessaires au soutien direct par la famille, les proches ou la personne de confiance, sauf opposition du patient. Respecter le rôle du médecin et le périmètre prévu; ce n'est pas une remise complète du dossier.
Police ou justice	Vérifier la réalité et la portée de la demande par un contact officiel indépendant. Transmettre au médecin, à la CRUA/direction ou au service juridique selon la procédure. Une réquisition a un cadre précis; ne pas en déduire une levée générale du secret.
Échanges entre soignants	Partager seulement les informations nécessaires à la prise en charge, avec les professionnels concernés et dans le cadre légal. Éviter couloirs, ascenseurs et conversations audibles par des tiers.

La vérification se prépare

À l'admission, demander au patient qui peut être informé, prévenu ou autorisé à lui rendre visite, puis tracer et actualiser ses choix. Les modalités d'appel et de rappel d'un service constituent une procédure locale, pas une interdiction légale universelle de tout échange téléphonique.

Protéger les documents, les écrans et les transmissions numériques. Les demandes judiciaires concernant un professionnel doivent être relayées pour rechercher l'accompagnement institutionnel approprié; aucune protection fonctionnelle automatique ne peut être promise.

Repère: CSP L1110-4, secret et exceptions légales; informations transmises selon la qualité du destinataire et la procédure de l'établissement.

Dossier: droit du patient et accès soignant

DEUX QUALITÉS, DEUX CIRCUITS

Le patient peut demander les informations de santé le concernant. Le professionnel accède au dossier pour exercer une mission autorisée, avec les informations nécessaires à celle-ci. Travailler dans l'établissement ne donne pas un droit de consultation par curiosité.

Je suis patient	Je suis professionnel
Je demande mes informations de santé par la procédure d'accès prévue.	Je consulte selon ma mission, mon habilitation et le besoin de prise en charge.
Identité et qualité vérifiées; demande au service compétent de l'établissement.	Accès justifié, informations nécessaires, session protégée. Jamais par curiosité.

Droit d'accès du patient ≠ permission d'utiliser une session professionnelle pour son propre dossier.

Dossier et outils	Ce qu'il faut comprendre
Contenu du dossier	Résultats, comptes rendus, prescriptions, surveillance et écrits infirmiers, correspondances et autres informations de santé formalisées. Le caractère infirmier d'une note ne la soustrait pas au droit d'accès.
Portail ou Mon espace santé	L'espace numérique et le dossier complet détenu par chaque professionnel/établissement ne se confondent pas. Tout résultat n'a pas un délai de disponibilité universel de 15 jours.
Session professionnelle	Utiliser son habilitation personnelle, verrouiller ou fermer la session et ne pas partager ses identifiants. Les consultations sont traçables et peuvent être contrôlées; l'outil et l'organisation varient selon le site.
Son propre dossier	Un soignant qui devient patient conserve son droit d'accès patient. Selon la politique d'accès présentée dans le cours, il utilise ce circuit pour son propre dossier et ne détourne pas sa session professionnelle.

Demander et transmettre le dossier

IDENTITÉ, QUALITÉ, PÉRIMÈTRE ET CONFIDENTIALITÉ

La demande est adressée au professionnel ou à l'établissement détenteur. L'accès peut être direct ou passer par un médecin désigné. Vérifier l'identité du demandeur et son titre à agir, puis organiser une consultation sur place ou une communication selon les modalités disponibles et adaptées.

Contrôle	Règle ou action utile
Délai habituel	Communication au plus tôt après 48 heures et au plus tard dans les 8 jours suivant la demande. Le délai peut être porté à 2 mois pour des informations de plus de 5 ans ou dans certaines situations psychiatriques prévues par les textes.
Mandataire	Vérifier le mandat spécifique et les identités nécessaires. Le conjoint d'un adulte vivant ne peut pas obtenir son dossier du seul fait du mariage.
Périmètre communicable	Communiquer les informations de santé accessibles. Exclure les informations recueillies auprès de tiers extérieurs à la prise en charge thérapeutique ou concernant ces tiers, selon les critères légaux.
Première copie	La première copie des données personnelles de santé est gratuite au titre du RGPD. Des copies supplémentaires peuvent donner lieu à des frais raisonnables sous conditions; la consultation sur place est gratuite.
Transmission	Vérifier destinataire et coordonnées; utiliser une enveloppe confidentielle ou un canal numérique institutionnel validé. Tracer la demande, les vérifications et la communication.

Ne pas confondre accompagnement et restriction

Des explications médicales peuvent aider à comprendre le dossier. Leur intérêt ne permet pas d'imposer, en dehors des cas légaux, un médecin intermédiaire ni de supprimer le droit d'accès. Le nom « notes personnelles » ne suffit pas à exclure une information formalisée utilisée dans le diagnostic ou les soins.

Première copie: repère actualisé

La gratuité d'une première copie ne constitue pas seulement une faveur locale de l'AP-HP. La CJUE a confirmé ce droit le 26 octobre 2023 (C-307/22). Ne pas annoncer systématiquement une facturation de première copie.

Service Public - accès au dossier; DAJ - première copie gratuite, arrêt C-307/22.

Dossier: situations particulières

APRÈS DÉCÈS, LE SECRET NE DISPARAÎT PAS

Situation	Conditions essentielles
Mineur	L'autorité parentale exerce en principe le droit d'accès. L'information et la participation du mineur sont adaptées à sa maturité. Certains soins relèvent d'exceptions légales protégeant son secret; orienter la demande vers le professionnel compétent.
Majeur protégé	Ne pas déduire un accès illimité du seul mot « tutelle ». Vérifier la mesure, sa portée pour la personne et les conditions légales de l'accès. L'assistance et la représentation ne sont pas interchangeables.
Patient décédé	En l'absence d'opposition exprimée de son vivant, les ayants droit, le concubin ou le partenaire de PACS peuvent obtenir les informations nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre sa mémoire ou faire valoir leurs droits. Vérifier la qualité et la finalité; ne pas remettre automatiquement tout le dossier à toute la famille.

Conservation en établissement de santé

Repère	Durée et condition
Principe	20 ans après le dernier séjour ou la dernière consultation externe dans l'établissement.
Patient décédé	Si le décès survient moins de 10 ans après le dernier passage: conservation 10 ans à compter du décès. Ce n'est pas une règle de 10 ans après tous les décès.
Dernier passage avant 8 ans	Prolonger la conservation jusqu'au 28e anniversaire.
Situations particulières	Les mentions d'actes transfusionnels suivent une conservation spécifique de 30 ans. Un recours mettant en cause la responsabilité médicale suspend les délais concernés.

Ces repères ne donnent pas à un soignant l'autorisation de détruire un dossier. La gestion et l'élimination des archives relèvent des responsables et procédures compétents. Les règles d'un cabinet libéral et celles de l'espace numérique de santé ne se confondent pas avec cette conservation hospitalière.

Biens et aides techniques du patient

PRÉVENIR LA PERTE, TRACER CHAQUE REMISE

L'inventaire protège les biens et permet d'assurer la continuité de l'autonomie. Expliquer les possibilités de dépôt et les risques de conservation auprès de soi. Rechercher explicitement les lunettes, prothèses dentaires, aides auditives et aides à la marche: le patient peut oublier de les citer.

Étape	Action et précision
1 · Repérer	Biens et aides : demander, voir et décrire avec le patient si possible.
2 · Informer	Expliquer dépôt, conservation, risques et modalités de retrait.
3 · Organiser	Régie, service ou remise à un proche selon le choix et la procédure.
4 · Tracer et suivre	Inventaire, reçu, remise ou refus ; mise à jour lors des transferts.

Patient incapable : organiser les formalités protectrices puis l'informer dès que possible.

Point pratique	Action à conserver
Description	Faire un inventaire contradictoire avec le patient lorsque possible, selon la procédure locale; tracer l'impossibilité ou le refus. Décrire « métal jaune » plutôt qu'affirmer « or » sans expertise.
Dépôt et remise	La régie reçoit les valeurs selon ses règles; certains effets utiles sont gérés par le service. Tracer les objets remis à un proche, l'identité du receveur et la remise. Anticiper les justificatifs du retrait.
Aides et transferts	Boîte identifiée pour les prothèses; éviter plateau et linge. Actualiser lors d'un transfert ou d'une nouvelle remise. Adapter le rangement au besoin d'utilisation, pas seulement à la sécurité du stockage.

Incapacité, urgence ou régie fermée

L'admission d'une personne incapable de faire les formalités impose une protection organisée de ses biens. Hors horaires, appliquer la procédure locale de garde et de remise; informer le patient dès que possible. Une perte peut compromettre alimentation, audition, mobilité et vie sociale.

L'indemnisation dépend du régime du dépôt, des circonstances et d'une faute éventuelle. Un refus de dépôt n'efface pas toute responsabilité ; aucune indemnisation automatique n'est promise. AP-HP - responsabilité pour biens non déposés.

Personne à prévenir ou de confiance?

EXPLIQUER LE RÔLE AVANT DE RECUEILLIR UN NOM

Ces deux rôles peuvent être tenus par la même personne, mais répondent à des besoins différents. Un nom renseigné dans une case ne prouve ni une désignation de confiance valable, ni un droit à toutes les informations médicales.

Question	Personne à prévenir	Personne de confiance
À quoi sert-elle?	Contact pratique: prévenir d'un événement, préparer des vêtements, organiser une sortie ou résoudre une difficulté matérielle.	Si le patient le souhaite: l'accompagner dans les démarches et entretiens, l'aider à comprendre et décider. S'il ne peut plus s'exprimer: témoigner de sa volonté.
Comment est-elle choisie?	Choix du patient, selon les modalités de recueil de l'établissement; un ou plusieurs contacts possibles.	Désignation par écrit et cosignée par la personne désignée. Le choix est facultatif, révisable et révocable.
Quelle portée?	Aucun droit général à l'information médicale ou à la décision du seul fait de ce rôle.	Son témoignage sur la volonté du patient prévaut sur les autres témoignages; elle ne remplace pas la décision du patient capable.
Accès au dossier?	Aucun accès automatique.	Aucun accès automatique du seul fait de la désignation; mandat ou autre titre à vérifier selon la demande.

Faire une désignation utile

Expliquer les missions et recueillir l'accord de la personne choisie, puis vérifier la cosignature, les coordonnées et l'actualité du document. Une personne éloignée peut être choisie; anticiper les modalités pratiques de signature et de contact. Le refus de désigner une personne est respecté et tracé.

La désignation de confiance est valable sans limitation de durée, sauf durée prévue par les personnes concernées. À chaque admission, vérifier le document existant et les souhaits actuels, sans présenter une nouvelle désignation comme obligatoirement nécessaire.

En cas de protection avec représentation relative à la personne: autorisation du juge ou du conseil de famille pour désigner une personne de confiance. CSP L1111-6, version du 28/05/2026.

Directives anticipées: préparer et retrouver

LA VOLONTÉ ACTUELLE DU PATIENT CAPABLE PRIME

Les directives anticipées permettent à une personne majeure d'exprimer à l'avance sa volonté sur les conditions de poursuite, de limitation, d'arrêt ou de refus de traitements ou d'actes médicaux en fin de vie, pour le moment où elle ne pourrait plus s'exprimer. Tant qu'elle peut exprimer sa volonté, il faut l'écouter directement.

Étape	Ce qu'il faut expliquer
Proposer sans imposer	Toute personne majeure peut envisager cette démarche, même sans maladie grave. Aider à comprendre le document et proposer un échange avec le professionnel compétent; ce n'est pas une formalité obligatoire à faire signer.
Rédiger et identifier	Document écrit, daté et signé, permettant d'identifier son auteur; un modèle peut aider. En cas de difficulté à écrire ou signer, rechercher l'aide et les modalités réglementaires adaptées. Un tiers ne choisit pas à la place de l'auteur.
Réviser	Le choix peut évoluer après une maladie, un événement de vie ou une nouvelle réflexion. Les directives sont révisables et révocables à tout moment; les plus récentes prévalent.
Retrouver	Signaler leur existence et leur emplacement: dossier médical partagé/Mon espace santé, médecin et personnes informées. Vérifier l'accès à la version actuelle; une volonté introuvable est difficile à appliquer.
Appliquer	Elles s'imposent au médecin dans le cadre légal. Exceptions: urgence vitale pendant l'évaluation complète, ou directives manifestement inappropriées/non conformes à la situation, après procédure collégiale et décision tracée.

Majeur protégé: actualisation de mai 2026

La rédaction des directives est un acte strictement personnel: le tuteur ne les rédige pas à la place de la personne. Le majeur en capacité de les rédiger le fait sans autorisation préalable du juge. Cette règle est différente de celle de la désignation d'une personne de confiance.

Si le patient ne peut plus s'exprimer et qu'aucune directive n'est disponible, l'équipe recherche sa volonté, notamment auprès de la personne de confiance, puis de la famille ou des proches selon le cadre légal. Leur témoignage n'est pas un vote pour choisir à sa place.

Service Public - directives anticipées, vérifié le 28/05/2026; CSP L1111-11 et code civil art.458. Les dispositifs spécifiques de fin de vie demandent une évaluation médicale propre.

Soigner un majeur protégé

LIRE LA MESURE ET ÉVALUER LA CAPACITÉ POUR LE SOIN

Sauvegarde, curatelle et tutelle ne produisent pas une incapacité uniforme à décider des soins. Consulter le jugement et identifier la personne chargée de la mesure. Une protection des biens ne donne pas, à elle seule, une représentation pour les décisions concernant la personne.

Situation	Décision et conduite
Patient apte à exprimer sa volonté	Le patient prend la décision pour sa santé après information adaptée, au besoin avec une assistance. Rechercher et obtenir son consentement, même en présence d'une mesure de représentation relative à la personne.
Patient non apte + représentation relative à la personne	La personne chargée de cette représentation donne l'autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par le patient. Vérifier sa qualité et la portée de la mesure, puis tracer.

Situation	Décision et conduite
Patient non apte sans représentation pour la personne	Appliquer le cadre du patient hors d'état de s'exprimer: consultation de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche, sauf urgence ou impossibilité. Ne pas inventer un pouvoir du gestionnaire des biens.
Désaccord patient/représentant	Sauf urgence, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. Rechercher le relais médical et juridique adapté.
Refus du représentant avec conséquences graves	Le médecin délivre les soins indispensables lorsque le refus risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé, selon les conditions légales.
Urgence et patient non apte	Le médecin apprécie et met en œuvre les soins indispensables dans le cadre légal. L'appel à la direction peut aider à organiser la réponse; il ne remplace pas le fondement légal de la décision médicale.

Information et participation

Parler au patient et lui expliquer le soin avec des moyens adaptés. Recueillir son avis même quand il ne peut pas consentir seul. Vérifier les coordonnées du représentant, sa compétence pour la personne et les documents utiles, sans assimiler tout proche à un représentant légal.

Synthèse actualisée du tableau du support p.50. CSP L1111-4 et code civil art.459. Les règles propres à un acte particulier restent applicables.

e-Satis: écouter le vécu après le séjour

UN QUESTIONNAIRE NATIONAL, UNE PARTICIPATION VOLONTAIRE

e-Satis mesure la satisfaction et l'expérience rapportées par les patients. Les questionnaires sont adaptés au type de prise en charge: notamment hospitalisation de plus de 48 heures en médecine-chirurgie-obstétrique, chirurgie ambulatoire et

autres programmes nationaux. Une consultation externe ne relève pas automatiquement du même questionnaire.

Étape	Action et précision
1 · Adresse recueillie	Information du patient et recueil selon le circuit de l'établissement.
2 · Lien après sortie	Pour un séjour de plus de 48 h en MCO : courriel environ deux semaines après le séjour.
3 · Réponse libre	Le patient décrit son expérience ; il reste libre de participer.
4 · Actions qualité	Analyser résultats et commentaires, décider des actions et les suivre.

Le questionnaire dépend du programme et des critères d'éligibilité; il n'est pas envoyé après toute consultation.

Ce qui est exploré	Exemples de points à améliorer
Accueil et relation	Disponibilité, écoute, explications, respect et possibilité de poser des questions.
Soins et aide	Douleur, assistance pour les actes courants, délai de réponse et coordination.
Environnement et sortie	Bruit, confort, repas, information anticipée et organisation de la sortie. Une qualité relationnelle appréciée peut coexister avec un problème d'environnement.

Rôle du soignant

Expliquer l'intérêt du questionnaire, vérifier le recueil de l'adresse selon la procédure et indiquer la possibilité d'un message dans les courriers indésirables. Le patient reste libre de répondre; son avis ne doit pas être orienté vers une note favorable.

Analyser les réponses et les commentaires permet de choisir des actions d'amélioration. Ne pas transformer quelques verbatims en proportion de tous les patients satisfaits ou insatisfaits: la participation et les profils des répondants influencent les résultats.

HAS - programmes e-Satis. Pour le programme +48h MCO, l'envoi du lien intervient environ deux semaines après la sortie, selon les conditions du recueil.

Expérience patient: écouter et agir

UNE DÉMARCHE QUALITATIVE AU LIT DU PATIENT

Les rencontres présentées dans le cours rassemblent notamment CRUA, RU, qualité et direction selon l'organisation locale. Avec l'accord des patients, l'entretien ouvert fait émerger ce qui a compté dans le séjour. Il complète les questionnaires; il ne vise pas à calculer un taux représentatif sur quelques entretiens.

Temps de la démarche	Application concrète
Recueillir	Expliquer le but, respecter le refus et laisser le patient décrire son vécu. Faire préciser les situations sans contester d'emblée son ressenti.
Comprendre	Distinguer qualité perçue, difficulté de communication, fait matériel et risque de soin. Reformuler en cas d'incompréhension, sans déduire un problème des origines ou de l'accent d'un professionnel.
Corriger	Résoudre un problème simple immédiatement lorsque possible: télécommande ou sonnette inaccessible, besoin d'explication, rangement d'une aide technique. Alerter pour une difficulté dépassant son rôle.
Partager et suivre	Débriefing, restitution aux équipes et responsables, plan d'action et suivi. Conserver ce qui fonctionne, y compris les remerciements, et expliquer les suites au patient.

Exemples tirés du cours

Des patients apprécient l'écoute et les explications, tout en signalant le bruit, les travaux, la propreté, l'horaire des repas ou une sortie annoncée trop tard. Un livret non remis ou un inventaire absent deviennent des actions concrètes: remise effective, explication et traçabilité lors des transferts.

Chiffres locaux: conserver le contexte

Pour Antoine-Béclère en 2025, le support rapporte 269 réclamations (dont 23 à caractère corporel et 41 matérielles), 5 médiations et 208 demandes de dossier. Pour les rencontres au lit: 13 séances et 41 patients. Ces nombres décrivent une activité locale datée; ils ne permettent pas, seuls, de mesurer la fréquence réelle des atteintes aux droits ni de comparer les hôpitaux.

La réception d'un témoignage négatif et celle d'un témoignage positif appellent la même attention au vécu et aux faits. Une mesure annoncée doit avoir un responsable et un suivi; écouter sans suite ne suffit pas à améliorer les soins.

Vie collective: droits et responsabilités

EXPLIQUER LES RÈGLES ET LES ADAPTER À LA SITUATION

Les responsabilités des usagers contribuent à la sécurité, au respect des autres patients et au fonctionnement des soins. Les dix repères ci-dessous reprennent le règlement local présenté dans le cours; l'établissement précise les modalités applicables et leurs adaptations.

Repère	Application
1. Courtoisie et calme	Respecter professionnels et autres patients; limiter le bruit des conversations, téléphones et téléviseurs. Signaler menaces ou violences et solliciter la protection adaptée.
2. Matériel	Respecter les locaux, équipements et biens de l'établissement.
3. Visites	Respecter les règles et horaires du service, les besoins de repos et les contraintes du soin. Examiner les adaptations possibles au cas par cas.
4. Convictions	Respecter les croyances, sans prosélytisme ni perturbation du fonctionnement, de la santé ou de l'hygiène.
5. Aliments extérieurs	Les faire valider par l'équipe: régime, jeûne, conservation et chaîne du froid peuvent être concernés.
6. Hygiène	Respecter les consignes d'hygiène et les gestes barrières adaptés.
7. Sortie de l'unité	Informer l'équipe avant de quitter l'unité, pour la sécurité et l'organisation des soins.
8. Images et enregistrements	Ne pas photographier, filmer ou enregistrer les professionnels ou d'autres patients sans autorisation, ni diffuser ces contenus sans respecter leurs droits. Attention : il ne s'agit pas d'une interdiction légale universelle de toute image prise dans sa propre chambre.
9. Tabac	Ne pas fumer à l'intérieur; respecter la signalisation et les espaces éventuellement autorisés à l'extérieur.
10. Objets interdits	Respecter l'interdiction des produits illicites et des armes.

Violence: protéger et alerter

Mettre en sécurité et demander un renfort selon la situation. Tracer et utiliser les circuits d'alerte; informer sur les accompagnements et démarches possibles, sans promettre qu'une plainte personnelle ou qu'une substitution par l'institution est automatique.

Cas pratique: plusieurs droits en jeu

PARTIR DES FAITS, PROTÉGER ET CORRIGER

Un patient après un AVC utilise des cannes. Elles ne sont pas retrouvées et aucun inventaire ne permet d'établir leur circuit. Il déclare qu'une protection absorbante lui a été imposée alors qu'il est continent. Il décrit aussi des professionnels non présentés et une porte ouverte pendant les soins.

Fait à analyser	Droit et conséquence	Action attendue
Cannes manquantes	Biens et autonomie: risque de perte de mobilité et de chute.	Rechercher les faits et les traces, signaler la perte, fournir une aide adaptée sans attendre l'issue de la réclamation; revoir inventaire et transferts.
Protection imposée	Dignité et consentement: le besoin doit être évalué, pas déduit d'une difficulté d'organisation.	Écouter le patient, apprécier continence et possibilités de déplacement, expliquer et convenir d'une aide appropriée.
Absence de présentation	Qualité de la relation et information.	Se présenter avec fonction et badge; expliquer qui fait quoi et le soin proposé.
Porte ouverte pendant le soin	Intimité corporelle et risque de divulgation d'informations.	Fermer la porte ou installer une protection adaptée; limiter les personnes présentes et recueillir les préférences du patient.

Démarche d'équipe

Écouter et sécuriser immédiatement; recueillir les éléments de chaque service; reconnaître les dysfonctionnements établis et expliquer les mesures prises. Les excuses et la réponse au patient ne remplacent pas la prévention de leur répétition.

Dans le cas présenté, l'enquête n'a pas retrouvé de traçabilité suffisante pour les cannes. Les actions discutées portent notamment sur une aide à la marche, l'inventaire, la pertinence de la protection, la présentation et le respect de l'intimité. L'indemnisation acceptée dans ce dossier ne crée pas une règle automatique pour toute perte.

Pour raisonner en stage

Décrire le fait observé, le besoin du patient, le droit concerné, l'action immédiate et le relais nécessaire. Une organisation difficile ne justifie pas de renoncer à l'évaluation, à l'explication et au respect de la personne.

Cas reformulé du support p.51-54. L'analyse associe réponse au patient, correction immédiate et prévention de la répétition.

ZOOM INFOGRAPHIQUE

Soins psychiatriques sans consentement

Chronologie clinique, orientation des soins et contrôle juridictionnel

1 · OBSERVATION ET ÉVALUATIONS

L.3211-2-2 CSP

J0

ADMISSION

Début de la période d'observation en hospitalisation complète.

≤ 24 H

BILAN INITIAL

Examen somatique complet + certificat psychiatrique.

≤ 72 H

RÉÉVALUATION

Nouveau certificat. Si maintien nécessaire, proposition de forme.

2 · CHOIX DE LA FORME DES SOINS

Autorité compétente, selon la procédure

MAINTIEN NÉCESSAIRE ?

Si non : levée

MESURE LEVÉE SI NON JUSTIFIÉE

L'absence de critères de maintien ne permet pas de prolonger la mesure.

Si oui : décision

FORME DE PRISE EN CHARGE

Hospitalisation complète ou autre modalité, selon décision motivée.

3 · GARANTIE JUDICIAIRE

Si hospitalisation complète maintenue

≤ J8

SAISINE

Le juge est saisi dans les huit jours.

< J12

DÉCISION

Le magistrat statue avant douze jours.

6 MOIS

RÉEXAMEN

Si hospitalisation complète continue.

PIÈGES DE PARTIEL

24 h / 72 h = évaluations médicales. J8 / J12 / 6 mois = contrôle judiciaire.
Le contrôle semestriel concerne l'hospitalisation complète continue.

À RETENIR · DEUX CIRCUITS DISTINCTS

L'état clinique et la légalité sont réévalués ; le juge peut être saisi à tout moment.

Sources : CSP L.3211-2-2 et L.3211-12-1 (vérifiés au 29/10/2026).

Pièges QCM et confusions à éviter

> **Méthode.** Identifier le régime juridique, la qualité de la personne qui demande, les conditions, l'exception et la conséquence pratique. Une affirmation vraie dans un cas particulier peut être fausse si elle est présentée comme une règle générale.

- Les droits s'appliquent aussi à la prévention, sans maladie diagnostiquée.
- Une mauvaise observance n'autorise pas automatiquement à refuser des soins.
- Continuité des soins et permanence des soins décrivent deux exigences complémentaires.
- Une conviction personnelle ne permet pas un refus arbitraire ou discriminatoire.
- Droit à des soins appropriés ne signifie pas droit à obtenir tout traitement demandé.
- Obligation de soulager ne signifie pas garantie de disparition de toute souffrance.
- Palliatif ne signifie ni abandon thérapeutique ni soins réservés à l'hôpital.
- Collégialité ne signifie pas vote de la famille ni décision prise par la personne de confiance.
- Souffrance réfractaire et souffrance insupportable après arrêt d'un traitement correspondent à des cas distincts.
- Les proches ou le protecteur ne peuvent pas demander une aide à mourir à la place d'une personne incapable d'exprimer sa volonté.
- Une limitation organisationnelle doit rester compatible avec la sécurité et les droits.
- Une personne connue ou un membre de la famille n'a pas, par ce seul lien, accès au dossier.
- Même hôpital n'équivaut pas à même équipe de soins pour tout dossier.
- Informer un apparenté d'une possibilité de risque génétique ne signifie pas lui transmettre librement le dossier du patient.
- Une dérogation autorisée n'est pas une autorisation générale de parler à n'importe qui.
- Un tarif affiché ne remplace pas l'entretien médical individualisé.
- « Risques fréquents ou graves » ne signifie pas « fréquents et graves ».
- Tutelle, curatelle et représentation relative à la personne ne sont pas interchangeables.
- Signature et consentement ne sont pas synonymes; la personne peut changer d'avis.
- Urgence chez une personne incapable de s'exprimer et refus éclairé d'un adulte capable sont deux situations différentes.
- Pas de durée de validité de trois ans depuis la réforme de 2016.
- Un seul parent ne suffit pas dès que le professionnel connaît un désaccord.
- Pour l'infirmier, le secret de L. 1111-5-1 concerne la santé sexuelle et reproductive.
- Le tuteur ne consent pas automatiquement à tous les soins; gravité corporelle et intimité privée ne sont pas synonymes.
- Autorisation du protecteur ne suffit pas pour une stérilisation ou un don encadré.
- Soins sans consentement ne signifie pas forcément hospitalisation complète permanente.
- Un certificat en urgence avec tiers et un certificat en péril imminent sans tiers ne sont pas équivalents.
- Le certificat initial de la voie préfectorale n'est pas réservé à un psychiatre extérieur.
- Le contrôle du juge ne remplace pas les certificats ni l'évaluation clinique continue.
- 12 h/48 h pour l'isolement et 6 h/24 h pour la contention sont des plafonds distincts, pas des durées imposées.
- Le registre institutionnel et les notes cliniques répondent à des exigences complémentaires.
- Décès n'implique pas toujours « dix ans »; première copie n'implique pas facturation systématique.

• CRUA = RU = CDU Une professionnelle de coordination, des représentants bénévoles et une commission: trois fonctions complémentaires. La médiation n'est pas un jugement.

• Silence ou signature = consentement

• Rechercher une décision comprise et libre; un consentement peut être retiré. Ne pas déduire l'accord du soin déjà réalisé.

• Proche = accès à toute information

• Vérifier la volonté du patient, l'identité et la qualité du demandeur. Personne à prévenir et personne de confiance ne donnent pas un droit automatique au dossier.

• Tutelle = patient privé de décision

• Apprécier l'aptitude et lire le jugement. Une représentation pour les biens n'est pas une représentation pour la personne.

• Confiance = directives anticipées

• La personne témoigne de la volonté; les directives expriment par écrit des choix anticipés. Les règles de désignation et de rédaction du majeur protégé diffèrent.

• Copie toujours payante / dossier unique

• Première copie des données gratuite; chaque professionnel ou établissement peut détenir un dossier. Mon espace santé ne les remplace pas tous.

• 20 ans / 10 ans sans condition 20 ans depuis le dernier passage hospitalier; 10 ans après décès seulement dans la situation prévue. Connaître les exceptions et ne pas décider soi-même d'une élimination.

• Pas de dépôt = jamais responsable

• Le régime dépend du dépôt, de l'information, des circonstances et d'une faute éventuelle. La prévention et la traçabilité restent essentielles.

• Questionnaire = avis de tous Participation volontaire et biais possibles. L'entretien au lit est une méthode qualitative, pas un échantillon représentatif automatique.

• Difficulté = contraindre ou abandonner

• Expliquer, adapter, alerter et assurer le relais. Le refus et les contraintes d'organisation n'effacent pas dignité, suivi et sécurité.

• Trois vérifications avant un geste ou une transmission

• Ai-je identifié la bonne personne? A-t-elle reçu une explication et exprimé son choix dans le cadre applicable? Suis-je autorisé et compétent pour agir ou transmettre cette information?

Synthèse générale — l'essentiel du cours

• Les droits des patients sont le cadre permanent de la relation de soin: accès, égalité, qualité, dignité, intimité, confidentialité, information, consentement et recours.

• Informer ne signifie pas seulement transmettre une donnée: il faut adapter le langage, vérifier la compréhension et distinguer les responsabilités de chacun.

• Le consentement doit être libre, éclairé et recherché pour le soin; un refus appelle information sur ses conséquences, dialogue, continuité de l'accompagnement et traçabilité.

• Secret professionnel, partage dans l'équipe, communication aux proches et accès au dossier répondent à des bases et à des conditions différentes.

• La personne de confiance, la personne à prévenir, les directives anticipées et les représentants légaux ne remplissent pas des fonctions interchangeables.

• L’expression de la volonté des mineurs, des majeurs protégés ou des personnes en soins psychiatriques doit être recherchée dans le régime légal applicable, avec des garanties spécifiques.

• Les décisions de fin de vie distinguent obstination déraisonnable, limitation/arrêt de traitement, soulagement et sédation profonde continue dans leurs indications et procédures.

• Les soins psychiatriques sans consentement sont encadrés: conditions d’admission, certificats, contrôle du juge, droit à l’information, réexamen et restrictions seulement dans les cadres prévus.

• Une réclamation, une perte de bien ou un défaut d’intimité se traite à partir de faits observés, de la parole du patient, d’actions proportionnées et de transmissions traçables.

• CRUA, représentants des usagers et CDU ont des rôles complémentaires; les enquêtes e-Satis et le recueil d’expérience servent à améliorer les soins et le parcours.

Définitions et mots-clés

Lexique consolidé — chaque terme reprend sa définition et, lorsqu'elle figure dans la fiche historique, sa nuance de révision et son origine lexicale. Ces précisions font partie de la notion à retenir.

Usager du système de santé

Personne bénéficiant notamment de prévention, dépistage ou soins, même sans maladie diagnostiquée.

À distinguer — Plus large que la seule personne malade.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Jurisprudence

Ensemble des décisions de justice dont l'interprétation éclaire l'application des règles de droit.

À distinguer — À distinguer d'une loi adoptée par le Parlement.

Construction : juris- (droit) + prudence (connaissance pratique, discernement).

Obligation de moyens

Exigence de mettre en œuvre les diligences et soins appropriés, sans garantir un résultat déterminé.

À distinguer — La persistance d'une maladie ne prouve pas, à elle seule, une faute.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Continuité des soins

Cohérence et relais du parcours pour éviter les ruptures de prise en charge.

À distinguer — Distincte de l'organisation de la permanence des soins.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Permanence des soins

Organisation d'une réponse aux besoins de soins dans les conditions légales, notamment hors des horaires usuels.

À distinguer — N'impose pas une disponibilité individuelle permanente de chaque professionnel.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Discrimination dans l'accès aux soins

Traitement défavorable fondé sur un motif prohibé, pouvant notamment prendre la forme d'un refus ou d'un délai injustifié.

À distinguer — Tout refus médicalement justifié n'est pas une discrimination.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Dignité

Valeur intrinsèque de toute personne fondant son droit inconditionnel au respect.

À distinguer — Elle ne dépend ni de l'autonomie fonctionnelle ni du comportement.

Construction : Du latin dignitas : valeur, considération.

Souffrance réfractaire

Souffrance qui ne peut être soulagée de façon satisfaisante par les traitements adaptés dans la situation considérée.

À distinguer — À distinguer de la seule intensité ou d'une souffrance dite insupportable dans un autre cas légal.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Obstination déraisonnable

Mise en œuvre ou poursuite d'actes inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie.

À distinguer — Une limitation de traitement n'est pas l'arrêt de l'accompagnement.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Procédure collégiale

Concertation requise dans certaines décisions médicales, notamment de fin de vie, pour examiner les conditions et la volonté du patient.

À distinguer — Elle n'est pas un vote donnant la décision aux proches.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Sédation profonde et continue jusqu'au décès

Altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie dans les situations légales prévues.

À distinguer — Distincte d'une sédation transitoire et de l'aide à mourir.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Aide à mourir

Recours à une substance létale dans le cadre et aux conditions propres de la loi de 2026.

À distinguer — Ne se confond pas avec les soins palliatifs ou la sédation profonde.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Secret professionnel

Obligation légale de ne pas divulguer les informations confidentielles connues du fait de sa profession, sauf exceptions prévues.

À distinguer — Le secret n'est pas réservé aux confidences expressément désignées comme secrètes.

Construction : secret (confidentialité) + professionnel (lié à la fonction).

Équipe de soins

Professionnels participant directement à la prise en charge d'un même patient et réunis dans les conditions légales de l'équipe.

À distinguer — Même établissement ne signifie pas droit d'accès à tous les dossiers.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Personne de confiance

Personne majeure désignée selon les formes prévues pour accompagner le patient et, si nécessaire, témoigner de sa volonté.

À distinguer — Ni personne à prévenir ni décideur médical substitué.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Dérogation au secret

Transmission d'informations autorisée ou imposée par un texte dans un périmètre déterminé.

À distinguer — Une exception limitée n'est pas une permission générale de divulguer.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Information préoccupante

Information transmise pour permettre l'évaluation d'un danger ou risque de danger concernant un mineur, selon le dispositif de protection de l'enfance.

À distinguer — À distinguer des voies d'urgence ou du signalement judiciaire selon la situation.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Consentement libre et éclairé

Accord donné sans contrainte après réception d'une information adaptée sur un acte ou une prise en charge.

À distinguer — Une signature ne suffit pas à le caractériser.

Construction : consentement (accord) + libre (sans contrainte) + éclairé (après information).

Discernement

Aptitude à comprendre une situation et à apprécier les conséquences d'un choix, à évaluer pour la décision concernée.

À distinguer — Ne se déduit pas du seul nom d'une mesure de protection.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Directives anticipées

Expression personnelle écrite d'un majeur sur sa fin de vie, destinée au cas où il ne pourrait plus exprimer sa volonté.

À distinguer — Elles ne sont pas une autorisation pour tous les actes futurs et n'expirent plus au bout de trois ans.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Acte usuel de l'autorité parentale

Acte relevant de la vie courante permettant une présomption d'accord de l'autre parent à l'égard d'un tiers de bonne foi.

À distinguer — La présomption ne vaut pas en cas de désaccord connu.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Curatelle

Mesure de protection organisant une assistance dans les conditions du jugement.

À distinguer — Elle ne vaut pas représentation automatique pour tous les soins.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Soins psychiatriques libres

Prise en charge psychiatrique reposant sur le consentement dans le cadre ordinaire des droits du patient.

À distinguer — Ils constituent le principe ; le diagnostic seul ne justifie pas la contrainte.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Soins à la demande d'un tiers

Voie d'admission sur décision du directeur, fondée sur les conditions cliniques légales et une demande de tiers habilité.

À distinguer — À distinguer du péril imminent sans demande de tiers.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Péril imminent

Situation permettant la voie spécifique d'admission sans demande de tiers obtenable, sous conditions, avec certificat médical extérieur.

À distinguer — Ce n'est pas une simple difficulté administrative.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Programme de soins

Forme de prise en charge psychiatrique sans consentement organisée autrement qu'en hospitalisation complète, selon les modalités légales.

À distinguer — Ne crée pas un pouvoir général de soin forcé à domicile.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Isolement

Mesure de dernier recours séparant le patient dans le cadre strict des soins psychiatriques sans consentement.

À distinguer — Ce n'est ni une sanction ni une mesure d'organisation courante.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Contention mécanique

Restriction mécanique des mouvements, de dernier recours, dans le cadre légal d'une mesure d'isolement.

À distinguer — Sa durée et ses renouvellements sont distincts de ceux de l'isolement.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Mainlevée

Décision mettant fin à une mesure juridique de restriction ou de protection dans le cadre concerné.

À distinguer — Elle ne se confond pas nécessairement avec la fin de tout soin.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

CDSP

Commission départementale des soins psychiatriques, chargée notamment du respect des droits des personnes concernées.

À distinguer — Distincte du juge ; elle intervient aussi dans certains conflits d'accès au dossier.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Soins palliatifs

Soins actifs et continus, introduits selon les besoins, visant les symptômes et les dimensions psychiques, sociales et spirituelles, avec accompagnement de l'entourage.

À distinguer — Ils ne signifient pas abandon des soins.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Ayant droit

Personne qui tient un droit d'une autre personne ; l'accès après décès dépend de la qualité et des finalités légales.

À distinguer — Un membre de la famille n'obtient pas automatiquement le dossier intégral.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Représentation relative à la personne

Mission judiciaire permettant au protecteur d'intervenir pour certaines décisions personnelles lorsque les conditions sont réunies.

À distinguer — Distincte d'une mesure limitée aux biens ; l'autonomie possible demeure recherchée.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

CADA

Commission d'accès aux documents administratifs, recours notamment pour l'accès à un dossier détenu par un établissement public.

À distinguer — Ce recours ne remplace pas toutes les voies propres aux établissements privés.

Construction : Expression juridique française : pas de racine médicale spécifique à mémoriser.

Intimité

Part de la vie et du corps qui doit être préservée des regards, des présences et des interventions non nécessaires ou non consenties.

Vie privée

Éléments personnels et relations dont la personne maîtrise la divulgation dans le cadre des droits applicables.

Confidentialité

Protection des informations contre leur accès ou leur divulgation à des personnes non autorisées.

Information adaptée

Explication loyale et intelligible, ajustée à la situation et à la compréhension de la personne, dans le champ de compétences du professionnel.

Refus de soin

Décision de ne pas recevoir un soin ou un traitement; elle appelle information, respect de la volonté, traçabilité et continuité de l'accompagnement selon le cadre légal.

Traçabilité

Enregistrement des faits, décisions, actions, transmissions et contrôles permettant de comprendre le déroulement d'une prise en charge.

CRUA

Chargée des relations avec les usagers et les associations; professionnelle qui coordonne ces relations selon l'organisation de l'établissement.

CDU

Commission des usagers; instance de l'établissement contribuant au respect des droits et à l'amélioration de l'accueil et de la prise en charge.

ARS

Agence régionale de santé; autorité régionale participant à l'organisation et au contrôle du système de santé et à la désignation des RU.

HAS

Haute Autorité de santé; autorité publique indépendante intervenant notamment dans l'évaluation, les recommandations et la certification.

Réclamation

Expression d'une insatisfaction adressée à l'établissement pour obtenir une réponse, une explication ou une action.

Médiation

Démarche destinée à faciliter les explications et le dialogue entre usager et établissement, sans se substituer à un jugement.

CCI

Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux; voie amiable soumise à des conditions, qui émet notamment un avis.

ONIAM

Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales; intervient dans les cas prévus par les textes.

Dossier médical

Ensemble des informations de santé formalisées détenues par un professionnel ou un établissement, dont l'accès obéit aux règles légales.

Mandat

Autorisation donnée à une personne pour accomplir une démarche au nom d'une autre; sa portée et l'identité des personnes doivent être vérifiées.

Personne à prévenir

Contact choisi pour être averti ou aider aux aspects pratiques; ce rôle ne donne pas de droit général aux informations de santé.

Majeur protégé

Adulte faisant l'objet d'une mesure de protection juridique dont il faut vérifier la nature et la portée, notamment pour la personne ou les biens.

Assistance / représentation

Aide pour décider ou agir / pouvoir d'agir au nom de la personne dans le périmètre légal prévu. Ces modalités ne sont pas interchangeables.

Inventaire contradictoire

Relevé des biens établi avec la participation de la personne lorsque possible, selon une procédure permettant d'en vérifier et tracer le contenu

Dépôt / régie

Remise organisée des biens selon la procédure de l'établissement / service chargé notamment de recevoir et restituer certaines valeurs.

e-Satis

Dispositif national de questionnaires recueillant satisfaction et expérience des patients, avec des programmes adaptés aux prises en charge.

Expérience patient

Vécu rapporté par une personne concernant son parcours et ses interactions avec les professionnels et l'organisation des soins.